

# LA MOBILISATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE (MOBSOC)

## A. MOBILISATION SOCIALE

### Objectif général

Ce cours vise à permettre l'étudiant IDE/SF/Mt de la L2 de conduire une séance de mobilisation sociale

### Objectifs spécifiques

Il doit être capable de :

- 1) Définir la mobilisation sociale
- 2) Citer les objectifs de la mobilisation sociale
- 3) Décrire les stratégies de communication utilisées dans la mobilisation sociale
- 4) Citer les acteurs de la mobilisation sociale
- 5) Citer les populations bénéficiaires de la mobilisation sociale
- 6) Citer les avantages de la mobilisation sociale
- 7) Citer les obstacles potentiels de la mobilisation sociale
- 8) Décrire les étapes de la mise en œuvre de la mobilisation sociale

## I. DEFINITION

La mobilisation sociale est le processus par lequel les ministères, les bailleurs de fonds, les partenaires de mise en œuvre et les communautés collaborent stratégiquement pour sensibiliser et créer et accroître la demande pour un objectif commun.

## II. BUT DE LA MOBILISATION SOCIALE

Elle a pour but de rallier à une cause et inciter à l'action le plus grand nombre de personnes afin d'atteindre un objectif social commun, grâce aux efforts et contributions de tous

## III. OBJECTIFS DE LA MOBILISATION SOCIALE

La mobilisation sociale est utilisée pour :

- accroître les connaissances ;
- faciliter le changement de comportement ;
- générer de la demande pour les services de santé généralement en utilisant des canaux de communication stratégiques.

### III. STRATEGIES DE COMMUNICATION UTILISEES DANS LA MOBILISATION SOCIALE

Les plus usuelles sont :

- La communication interpersonnelle (dans la formation des agents de santé communautaires) ;
- La communication de masse (sous forme de chansons, de jeux radiophoniques et de médias similaires) ;
- Le plaidoyer au niveau communautaire (en engageant les communautés et leurs dirigeants dans les réunions).

### IV. POPULATION BENEFICIAIRES DE LA MOBILISATION SOCIALE

- Les personnes physiques ;
- Les entités morales ;
- La société toute entière.

### IV. LES ACTEURS DE LA MOBILISATION SOCIALE

- Les gouvernements ;
- Les ministères ;
- Les partenaires de mise en œuvre (Organisation Non Gouvernementales) ;
- Autres intervenants clés (organisations internationales).

### V. AVANTAGES DE LA MOBILISATION SOCIALE

La mobilisation sociale permet :

- d'atteindre des personnes qui ne peuvent entrer en contact avec le système de santé, en particulier les groupes marginalisés ;
- d'amener les gens à parler de problème de santé ;  
de sensibiliser le grand public autour des problèmes de santé
- d'utiliser des situations réelles dans les langues locales pour décrire les situations sanitaires ;
- d'élargir la portée des messages en attirant des foules lors d'événements ou en créant une suite grandissante, dans le cas d'une série de dramatiques radiophoniques ;
- de réduire et éliminer les mythes et les idées fausses autour des problèmes de santé, etc.

## **V. OBSTACLES POTENTIELLES A LA MOBILISATION SOCIALE**

Les limites potentielles à la mobilisation sociale pourraient être :

- Le Manque d'équipement, formation, motivation ou compensation/incitatifs ;
- Le trop peu de mobilisateurs, tels que les pairs éducateurs, les travailleurs de la santé etc. ;
- Les Matériaux limités ;
- Le Soutien logistique médiocre.

## **VII. ETAPES DE LA MISE EN ŒUVRE D'UNE MOBILISATION SOCIALE**

*sociale 6 étapes*

### **7.1 Évaluez les besoins, les problèmes et les ressources de la communauté**

Avant de concevoir et de planifier un programme de mobilisation sociale, il est utile de comprendre le contexte dans lequel vous allez mettre en œuvre le programme, y compris les facilitateurs potentiels et les obstacles à la mise en œuvre du programme et les ressources disponibles.

### **7.2 Concevoir une stratégie de mobilisation sociale**

Idéalement, vous devriez mettre au point une stratégie de mobilisation sociale dans un cadre communautaire participatif de type atelier. La stratégie de mobilisation sociale comprendra une description du plan global de mise en œuvre, y compris :

- Comment les mobilisateurs sociaux seront sélectionnés ?
- Quels rôles et responsabilités ils assumeront ?
- Quelles activités seront menées et pourquoi ?
- Comment les mobilisateurs sociaux seront formés et supervisés ?
- Quels matériaux et équipements ils peuvent avoir besoin ?
- Comment la stratégie sera surveillée et, éventuellement, évaluée ?

### **7.3 Identifier et collaborer avec les organisations locales**

Les ONG qui exécuteront et géreront les activités de mobilisation sociale, y compris la supervision et la coordination des mobilisateurs sociaux au niveau communautaire, devraient répondre à des critères spécifiques avant d'être choisies. Par exemple

- Être inscrit comme organisme corporatif ;
- Avoir de l'expérience dans le problème de santé sur lequel va porter la mobilisation sociale ;
- Avoir un système financier fonctionnel, etc.

#### 7.4 Concevoir, tester et produire des matériels de mobilisation sociale

Des documents de mobilisation sociale peuvent être élaborés dans le cadre d'un atelier qui comprend les initiateurs, les intervenants et éventuellement, les graphistes ou les artistes.

Ces matériaux peuvent être par exemple :

- Les langues locales, des phrases ou des mots qui permettraient de mieux communiquer l'objectif du programme ;
- Les cartes de référence et badges de marque, épinglettes, sacs, chemises, vestes, stylos) ;
- Les outils ou des kits de mise en œuvre ;
- Les brochures ou des listes de contrôle pour les animateurs et les mobilisateurs sociaux, etc.

#### 7.5 Sélectionner et former des mobilisateurs sociaux

Les mobilisateurs sociaux potentiels doivent répondre à des critères spécifiques afin d'être sélectionnés. Par exemple, les mobilisateurs potentiels doivent :

- Être prêt à faire du bénévolat ;
- Avoir plus de 18ans ;
- Vivre dans les communautés ;
- Exercer un petit métier (conducteur, mécanicien ou tailleur).

#### 7.6 Mettre en œuvre et surveiller les activités de mobilisation sociale.

Il est crucial non seulement de mettre en œuvre des activités, mais aussi de les surveiller. En mesurant les progrès, les initiateurs peuvent prendre des décisions et ajuster les plans en fonction des imperfections.

## B MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

### Objectif général

Ce cours vise à permettre l'étudiant IDE/SF/Mt de la L2 d'aider les populations à s'organiser pour une séance de mobilisation communautaire.

### Objectifs spécifiques

Il doit être capable de :

- 1) Définir la mobilisation communautaire
- 2) Enumérer le but de la mobilisation communautaire
- 3) Citer les principes fondamentaux de la mobilisation
- 4) Enumérer les populations bénéficiaires de la mobilisation communautaire
- 5) Citer les acteurs de la mobilisation communautaire
- 6) Citer les outils de la mobilisation communautaire
- 7) Enumérer les obstacles à la mobilisation communautaire
- 8) Décrire brièvement les étapes de la mobilisation communautaire
- 9) Citer les rôles de l'agent de santé dans la mobilisation communautaire

### I. DEFINITION

La mobilisation communautaire est un processus en vertu duquel des groupes locaux reçoivent de l'assistance afin de définir et exprimer leurs besoins et objectifs en prenant des mesures collectives visant à les satisfaire.

### II. BUT DE LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

Elle a pour but d'éviter le risque d'imposer des solutions extérieures et inappropriées aux besoins réels de la communauté

### III. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

La mobilisation communautaire suppose que :

- les problèmes sont vécus de façon collective ;
- les populations (y compris celles qui, dans d'autres situations, pourraient être "considérées" comme vulnérables) disposent de nombreuses ressources et vise à les optimiser ;
- les ressources communautaires sont complétées, uniquement lorsque cela est nécessaire et opportun, par des ressources extérieures spécifiques
- la communauté définisse ses propres besoins et objectifs ;

- la planification et la prise de décision relèvent de la compétence de la communauté et s'effectue du bas vers le haut et non du haut vers le bas ;
- les intérêts de l'ensemble de la communauté prennent le pas sur ceux des individus ;
- le sentiment d'appropriation de la part des populations elles-mêmes permet non seulement de veiller à ce que les programmes reflètent leurs culture et valeurs, mais également à assurer la durabilité.

#### IV. POPULATIONS BENEFICIAIRES DE LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

- L'individu : ++
- La famille ;
- La communauté.

#### V. LES ACTEURS DE LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

- Les organisations à base communautaire (organisation de jeunesse);
- Les leaders communautaires (Président de l'association de développement)
- les relais communautaires (Agent de Santé Communautaire par exemple)

#### VI. LES OUTILS DE LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

- La communication de masse : campagne médiatique (émissions radio locale, TV, presse écrite et en ligne).
- Les assemblées communautaires (quartiers/villages).
- La communication interpersonnelle : visites à domicile, causeries, etc.
- Le plaidoyer.

#### VII. LES OBSTACLES POTENTIELS A LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

- Les activités nécessitent beaucoup de temps et ne produisent pas nécessairement des résultats rapides ou visibles.
- Difficultés d'abandonner l'approche classique qui consistait à "entreprendre les activités pour la communauté"
- Difficultés dans la remise du pouvoir décisionnel à la communauté
- Les ressources locales disponibles ne permettent pas de satisfaire les besoins exprimés par les communautés
- Difficultés à collaborer avec les organismes extérieurs

## VIII. ETAPES DE LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

communautaire  
3 étapes

La mobilisation communautaire comporte trois étapes :

1-2-3

1. La planification des activités : Elle consiste à identifier les objectifs généraux ainsi que les objectifs spécifiques.
2. La mise en œuvre des activités. (Exécution des activités selon le plan établi).
3. Le suivi et évaluation. Il se fait pendant et à la fin de l'exécution des activités.

## IX. ROLES DE L'AGENT DE SANTE DANS LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

Le rôle de de l'agent de santé consiste à :

- aider les populations à s'organiser, préciser les idées concernant les besoins, les objectifs, les voies et moyens de les satisfaire et de les réaliser, etc. En d'autres termes le rôle d'élément catalyseur : *AAA*
- aider à promouvoir le leadership représentatif et les structures démocratiques ;
- fournir des connaissances et des informations ;
- fournir/faire le plaidoyer pour les ressources en vue d'appuyer les efforts de la communauté elle-même et compléter (et non remplacer) leurs propres ressources. Celles-ci pourraient comprendre la formation.

# EPIDEMIOLOGIE (ETUDE DES INDICATEURS DE SANTE)

## Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L2 de calculer les indicateurs de santé à partir des données sanitaires

## Objectifs spécifiques

A la fin du cours, il doit être capable de :

- 1) Définir l'indicateur de santé
- 2) Citer les différents groupes d'indicateurs de santé
- 3) Calculer les indicateurs de santé à tendance positive et à tendance négative

## I. DEFINITION D'UN INDICATEUR DE SANTE

Un indicateur de santé est une mesure qui permet d'analyser une situation sanitaire de base, de quantifier les changements intervenus et d'évaluer l'efficacité des actions et leur l'impact sur la population.

## II. DIFFERENTS GROUPES D'INDICATEURS DE SANTE

Nous avons deux grands groupes :

- Les indicateurs de santé à tendance positive ;
- Les indicateurs de santé à tendance négative.

## III. CALCUL DES INDICATEURS A TENDENCE POSITIVE ET NEGATIVE

Deux méthodes sont utilisées pour calculer le dénominateur qui peut être la **population moyenne** ou **population totale**.

- ✚ Au cas où le texte ou le sujet mentionne une population totale ou population de fin d'année, vous divisez le numérateur par la population totale.

**Exemple :** le nombre de naissances vivantes dans une localité est de 10 pour une population totale de 500 habitants

$$\text{Le TBN} = \frac{10}{500} \times 100 =$$

- ✚ Au cas où le texte ou le sujet mentionne deux populations (une population de départ et une population d'arrivée), vous divisez le numérateur par la population moyenne

Exemple : le nombre de naissances vivantes dans une localité est de 10 pour une population de départ de 500 habitants et une population d'arrivée de 600 habitants

$$\text{Le TBN} = \frac{10}{(500+600)/2} \times 100 =$$

#### ✓ Formule pour le calcul de la population moyenne

$$\text{Pop Moy} = \frac{\text{Pop de départ} + \text{Pop d'arrivée}}{2}$$

### 3.1 INDICATEURS A TENDENCE POSITIVE

#### ✓ Taux brut de natalité :

Il se calcule en divisant le nombre de naissances vivantes en une année donnée par la population totale ou moyenne x 100.

*Formule*

$$\text{TBN} = \frac{\text{Naissances Vivantes en 1an}}{\text{Moyenne de la même année}} \times 100$$

#### ✓ Taux d'accouchement assisté (TAA)

Il se calcule en divisant le total d'accouchements conduits par une personne qualifiée (médecin, infirmier, sage-femmes, etc.) ou ayant au moins une qualification d'accoucheuse traditionnelle en 1an par le total d'accouchement attendus de l'année x 100

Un accouchement est dit assisté lorsqu'il est conduit par une personne qualifiée ou ayant au moins la qualification d'accoucheuse traditionnelle.

### Formule

Effectif des femmes enceintes ayant été assistées pendant l'accouchement par une personne qualifiée ou ayant au moins une qualification d'accoucheuse traditionnelle pendant 1 an

$$TAA = \frac{\text{Effectif des femmes enceintes...}}{\text{Nombre d'accouchements attendus de la même année}} \times 100$$

### ✓ Taux Général de Fécondité (T.G.F)

Il s'obtient en divisant le nombre de naissances vivantes d'une année par le nombre de femmes en âge de reproduction de la même année (FAR) x 100

### Formule

$$TGF = \frac{\text{Naissances Vivantes dans une année}}{\text{Nombre de FAR de la même année}} \times 100$$

Rappelons que les FAR = 20% de la population totale et **non** la population moyenne

**Exemple :** le nombre de naissances vivantes enregistrées dans la localité de LOPOU est de 10 pour une population totale de 5000 habitants, Calculez le TGF

Je connais le numérateur qui est 10 et non le dénominateur, donc je calcule le dénominateur

$$FAR = 5000 \text{ habitants} \times 20 / 100 = 1000 \text{ FAR}$$

$$TGF = 10 / 1000 \times 100 = 1\%$$

### ✓ Taux d'accroissement Naturel (T.A.N)

Il se calcule en divisant l'accroissement naturel pendant une année par la population totale ou moyenne de la même année x 100

L'accroissement naturel étant égal au nombre de naissances pendant une année moins le nombre de décès au cours de la même année

### Formule

$$TAN = \frac{\text{Naissances} - \text{Décès d'une année}}{\text{Population totale de la même année}} \times 100$$

### ✓ Taux d'accroissement Annuel (T.A.A)

Il se calcule en divisant l'accroissement annuel pendant une année, par la population du début de la même année x 100

L'accroissement annuel étant égal à la population de fin d'année moins la population de début d'année.

#### Formule

$$TAA = \frac{\text{Pop de fin d'année} - \text{Pop de début d'année}}{\text{Pop de début d'année}} \times 100$$

**Exemple :** la localité de Tiendiekro compte 3700 habitants au début d'année 2020 et 4500 habitants à la fin de la même année.

$$\text{Le TAA} = 4500 \text{ habitants} - 3700 \text{ habitants} / 3700 \text{ habitants} \times 100 = 21,62\%$$

### ✓ Equation de projection Démographique (Equation de projection de la population)

Elle est utilisée pour actualiser une population ou pour la mettre à jour ou projeter une population sur une ou plusieurs années.

#### Formule

$$P_t = P_o (1 + r)^t$$

### ✓ Calcul du temps de dédoublement (TD) d'une population

Il se calcule en divisant 70 par le TAA en pourcentage

#### Formule

$$TD = 70 / \text{TAA en pourcentage}$$

**Exemple :** le TAA d'une localité donnée est de 2%, le temps de dédoublement est égal  $70 / 2 = 35$  ans

### ✓ Calcul de l'année de dédoublement (AD) d'une population

Il se calcule en additionnant l'année de repère plus le temps de dédoublement

#### Formule

$$AD = \text{année de repère} + \text{le temps de dédoublement}$$

**Exemple :** Si l'année de repère est 2022, l'AD sera égale :  $2022 + 35 = 2055$

### 3.2 LES INDICATEURS DE SANTE A TENDANCE NEGATIVE.

Ils se subdivisent en deux (2) sous-groupes

- Les indicateurs de morbidité : ils mesurent la maladie
- Les indicateurs de mortalité : ils mesurent les décès

#### 3.2.1. LES INDICATEURS DE MORBIDITE

##### ✓ *Taux Brut de Morbidité (TBM)*

Il se calcule en divisant le nombre de personnes tombées malades pendant une année donnée par la population totale ou moyenne de la même année x 100.

*Formule*

$$\text{Taux de morbidité} = \frac{\text{Effectif des personnes tombées malades en 1 an}}{\text{Population totale ou moyenne de la même année}} \times 100$$

##### ✓ *Le taux d'incidence.*

Il s'obtient en rapportant le total de nouveaux cas d'une maladie en 1 an par la population totale ou moyenne de la même année x 100

**L'incidence étant le nombre de nouveaux cas d'une maladie enregistré en 1 an.**

*Formule*

$$\text{TI} = \frac{\text{Nouveaux cas d'une maladie en 1 an}}{\text{Population totale ou moyenne de la même année}} \times 100$$

##### ✓ *Taux de Prévalence ou la prévalence*

C'est le total de personnes qui ont une maladie à un instant précis (anciens et nouveaux cas) au cours d'une année, rapportés à la population totale ou moyenne de la même année x100

La prévalence étant le nombre de cas de maladie (anciens plus nouveaux cas).

*Formule*

$$\text{Prévalence} = \frac{\text{Nbre de cas de maladies (anciens + nouveaux) pendant une année}}{\text{Population totale ou moyenne de la même année}} \times 100$$

### 3.2.2 LES INDICATEURS DE MORTALITE

#### ✓ Taux Brut de Mortalité (TBM)

Il se calcule en divisant le total de décès (toutes causes confondues) d'une année par la population totale ou moyenne de la même année x 100.

*Formule*

$$\text{TBM} = \frac{\text{Nombre de décès (toutes causes confondues) d'une année}}{\text{Population totale ou moyenne de l'année}} \times 1000$$

#### ✓ Taux de Mortalité Spécifique (TMS)

Il se calcule en rapportant le total de décès causé par une maladie donnée pendant une année par la population totale ou moyenne de la même année x 100.

*Formule*

$$\text{T.M.S} = \frac{\text{Total décès d'une année causé par une maladie}}{\text{Population totale ou moyenne de la même année}} \times 10^n$$

#### ✓ Taux de létalité (TL)

Il se calcule en divisant le total de décès d'une année causé par une maladie par le total de cas de la même maladie x 100

La létalité étant le total de décès causés par une maladie donnée.

*Formule*

$$\text{TL} = \frac{\text{Total décès d'une année causé par une maladie}}{\text{Total de cas de la même maladie de la même année}} \times 100$$

#### ✓ Taux de Mortalité Infantile (TMI)

Il s'obtient en divisant le total de décès des enfants de 0-11 mois d'une année par le total de naissances vivantes de la même année x 1000.

La mortalité infantile étant le décès qui survient chez les enfants de 0-11 mois.

La proportion des enfants de 1 à 4 ans est égale à 17,32% de la population totale

*Formule*

$$\text{TMI} = \frac{\text{Nombre de décès d'enfants de 0-11 mois d'une année}}{\text{Total des naissances vivantes de la même année}} \times 1000$$

### ✓ Taux de Mortalité Juvénile

Il s'obtient en divisant le total de décès des enfants de 1-4 ans d'une année par le total des enfants de 1-4 ans de la même année x 100

La mortalité juvénile étant le décès qui survie chez les enfants de 1-4ans.

La proportion des enfants de 1 à 4 ans est égale à 17,32 % de la population totale

#### *Formule*

$$TMJ = \frac{\text{Décès des enfants de (1 à 4 ans) d'une année}}{\text{Total des enfants de 1 à 4 ans de la même année}} \times 100$$

### ✓ Taux de Mortalité Maternelle (TMM)

Il se calcule en divisant le nombre de décès survenant chez une femme pendant la grossesse, l'accouchement, et quarante-deux (42) jours après l'accouchement par le nombre de naissances vivantes x 100000.

#### *Formule*

$$TMM = \frac{\text{Décès de femmes pendant la grossesse, l'accouchement et 42 jours après l'accouchement, ni accidentel, ni fortuit pendant une année}}{\text{Naissances vivantes de la même année}} \times 100000$$

La mortalité maternelle étant les décès de femme survenus pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou dans un délai de 42 jours après l'accouchement pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu'elle a motivés, mais ni accidentelle, ni fortuite (OMS)

### ✓ Taux de mortalité néonatale (TMNN).

Il se calcule en divisant le nombre de décès des enfants de 0 à moins de 28 jours pendant une année par le total des naissances vivantes de la même année x100

La mortalité néonatale étant le décès des enfants de 0 à moins de 28 jours.

#### *Formule*

$$TMNN = \frac{\text{Nombre de décès des enfants de 0 à moins de 28 jours d'une année}}{\text{Total de naissances vivantes de la même année}} \times 100$$

✓ **Taux de mortalité néonatale précoce (TMNNP)**

Il se calcule en divisant le nombre de décès des enfants de 0 à moins de 8 jours pendant une année, par le total des naissances vivantes de la même année x100

La mortalité néonatale précoce étant le décès des enfants de 0 à moins de 8 jours.

**Formule**

$$\text{TMNNP} = \frac{\text{Nombre de décès d'enfants de 0 à moins de 8 jours pendant 1 année}}{\text{Total de naissances vivantes de la même année}} \times 100$$

✓ **Taux de mortalité néonatal tardif (TMNNT)**

Il se calcule en divisant le nombre de décès des enfants de 8 à moins de 28 jours pendant une année par le total des naissances vivantes de la même année x100

La mortalité néonatale tardive étant le décès des enfants de 8 à moins de 28 jours

**Formule**

$$\text{TMNNT} = \frac{\text{Nombre de décès d'enfants de 8 à moins de 28 jours pdt une année}}{\text{Total des naissances vivantes de la même année}} \times 100$$

✓ **Taux de mortalité post-néonatale (TMPNN)**

Il se calcule en divisant le nombre de décès d'enfants de 28 jours à 11 mois pendant une année par le total des naissances vivantes de la même année x100

La mortalité post néonatale étant le décès des enfants de 28 jours à 11 mois.

**Formule**

$$\text{TMPNN} = \frac{\text{Nombre de décès d'enfants de 28 jours à 11 mois}}{\text{Total des naissances vivantes de la même année}} \times 100$$

## LA CHAÎNE DU FROID

### Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L2 à assurer l'efficacité des vaccins dans un centre de vaccination

### Objectifs spécifiques

A la fin du cours, il doit être capable de :

- 1) Définir la chaîne de froid
- 2) Citer les raisons du maintien d'une bonne chaîne de froid
- 3) Citer les matériels de la CDF
- 4) Citer les techniques d'entretien préventif du réfrigérateur
- 5) Citer les précautions à prendre pour éviter de rompre la CDF
- 6) Citer les éléments de la conduite à tenir en cas de rupture de la CDF
- 7) Citer les éléments de surveillance de la CDF
- 8) Décrire les techniques utilisées pour le contrôle de l'efficacité des vaccins
- 9) Décrire les dispositions à prendre pour le bon fonctionnement du réfrigérateur

### I. DEFINITION

La chaîne du froid (CDF) consiste en une série de modalités de conservation et de transport, toutes destinées à conserver les vaccins à une température acceptable jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'utilisateur.

### II. RAISONS FONDAMENTALE DE MAINTIEN DE LA CDF

Le maintien de la chaîne du froid est important dans le cadre des activités de vaccination pour trois raisons fondamentales :

- Les vaccins sont thermosensibles ;
- L'altération des vaccins est irréversible ;
- Les effets successifs des altérations s'additionnent.

### III. MATERIELS DE LA CHAÎNE DU FROID

#### 3.1. Matériels qui produisent du froid

- Les chambres froides ;
- Les congélateurs ;
- Les réfrigérateurs.

#### 3.2. Matériels qui conservent le froid

- Les emballages isothermes ;
- Les glacières proprement dites ;
- Les porte-vaccins ou glacières portatives ;
- Les coussinets en mousse ;
- Les accumulateurs de froid.

#### 3.3. Le matériel de monitoring de la CDF utilisés au centre de santé

- La fiche de contrôle de la T° du frigo
- Les pastilles de contrôle des vaccins (PCV) ;
- Le thermomètre ;
- Les indicateurs de congélation.

### VI. TECHNIQUES D'ENTRETIEN PREVENTIF DU REFRIGERATEUR

- Dégivrage fréquent et régulier dès que la couche de glace atteint 0,5 cm ;
- Dépoussiérage de la tuyauterie à l'arrière avec une brosse à poils souples ;
- Contrôle de l'étanchéité du joint de la porte par le test de la feuille de papier.

### V. PRECAUTIONS POUR EVITER DE ROMPRE LA CHAÎNE DE FROID

- Réceptionner les vaccins chez le fabricant ou à l'aéroport dès que possible ;
- Les transporter à une température comprise entre +2°C et +8°C depuis L'aéroport ou d'un magasin à l'autre ;
- Les conserver à la bonne température dans les magasins principaux/centraux et intermédiaires, ainsi que dans les centres de santé ;
- Les transporter à une température comprise entre +2°C et +8°C jusqu'au postes avancés et au cours des déplacements des équipes mobiles ;

- Les conserver à la température comprise entre  $+2^{\circ}\text{C}$  et  $+8^{\circ}\text{C}$  pendant les séances de vaccination ;
- Conserver à la température comprise entre  $+2^{\circ}\text{C}$  et  $+8^{\circ}\text{C}$  durant le retour aux centres de santé.

## **VI. CONDUITE A TENIR EN CAS DE RUPTURE DE LA CHAÎNE DE FROID**

Si les vaccins sont exposés à la chaleur :

- Regarder les pastilles de contrôle des vaccins qui en possèdent ;
- Si les pastilles virent, on ne peut plus les utiliser ;
- Pour les vaccins sans pastilles, il faut vérifier s'il reste de la glace dans le réfrigérateur ou dans les accumulateurs ;
- Si oui, les vaccins sont probablement intacts ; dans ces conditions il faut les ranger en sécurité dans une glacière avec la glace et les utiliser jusqu'à la fonte totale de la glace ;
- Si non, ils sont probablement altérés. Il faut donc les rendre au coordinateur du programme élargi de vaccination (CPEV) du district en échange d'un nouveau stock et accompagner les vaccins d'un document écrit. (Portant les références et la quantité des vaccins altérés.)
- En cas d'une panne du réfrigérateur, il faut stocker les vaccins dans le réfrigérateur d'une localité voisine.
- Si les vaccins sont exposés à la congélation :
- Dans le cas des vaccins liquides ou anatoxines, on pratique le test d'agitation des anatoxines.

## **VII. SURVEILLANCE DE LA CHAÎNE DU FROID**

### **7.1. Relevé biquotidien de la température**

- Lire la température chaque matin et chaque soir et la noter sur une feuille de température collée sur le réfrigérateur de préférence aux mêmes heures
- Si la température monte au-dessus de  $+6^{\circ}\text{C}$  ou descend en dessous de  $+2^{\circ}\text{C}$ , il faut régler le thermostat pour qu'elle reste entre 0 et  $+8^{\circ}\text{C}$

### **7.2. Utilisation des indicateurs de froid**

Utiliser les indicateurs de froid qui sont des instruments dont la couleur change quand la température est trop élevée ou trop basse (pastille de contrôle par exemple).

### **7.3. Test d'agitation des anatoxines**

Lorsqu'un stock d'anatoxine est suspecté d'avoir été congelé, il faut le comparer avec un flacon non suspect du même fabricant en procédant comme suit :

Agiter et les disposer sur un plan horizontal pendant une heure. Dans le flacon congelé, la sédimentation est plus rapide alors que le flacon indemne reste homogène.

### **7.4. Plan de sauvetage des vaccins en situation d'urgence**

Il faut afficher sur le réfrigérateur, une étiquette avec le nom, l'adresse et toutes les coordonnées du responsable des vaccins.

## **VIII. TECHNIQUES DE CONTROLE DE L'EFFICACITE DES VACCINS**

### **8.1 Le relevé de la température du réfrigérateur.**

Elle doit être relevée de façon biquotidienne (matin et soir) et si possible à des heures précises et notée sur la fiche réservée à cet effet. Il permet de vérifier si les vaccins non congelables ne sont pas exposés à la congélation.

### **8.2 La pastille de contrôle de vaccins (PCV).**

Elle permet de réduire les pertes de vaccins et d'éviter l'utilisation de vaccin endommagé. Elle est placée sur l'étiquette des flacons de vaccin liquide et sur la fermeture en plastique des flacons de vaccin en poudre ou à reconstituer.

## ✓ Interprétation de la PCV

Figure 6A : Ce que la pastille de contrôle du vaccin indique



Le carré est plus clair que le cercle.  
*Si la date limite d'utilisation n'est pas dépassée, UTILISER le vaccin.*



Un peu plus tard, le carré est toujours plus clair que le cercle.  
*Si la date limite d'utilisation n'est pas dépassée, UTILISER le vaccin.*



Point limite  
Le carré est de la même couleur que le cercle.  
*NE PAS utiliser le vaccin. Avisez votre superviseur.*



Au-delà du point limite  
Le carré est plus sombre que le cercle.  
*NE PAS utiliser le vaccin. Avisez votre superviseur.*

## IX. DISPOSITIONS POUR LE BON FONCTIONNEMENT DU REFRIGERATEUR

Veiller à installer correctement le réfrigérateur à l'abri du soleil et de la chaleur dans un local frais à une distance de 15 à 30 cm du mur ;

- Surélever le réfrigérateur sur des cales hautes de 5 cm ;
- Veiller à limiter les pertes de froid, pour se faire, ne l'ouvrir qu'en cas de nécessité de service ;
- Entretenir régulièrement en nettoyant et en dégivrant le réfrigérateur.

# **GESTION DES VACCINS ET CONSOMMABLES AU NIVEAU DES CENTRES VACCINATEURS**

## **Objectif général**

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L2 de gérer de façon efficace les vaccins et consommables au niveau d'un centre de vaccination.

## **Objectifs spécifiques**

A la fin du cours, il doit être capable

- 1) Définir quelques concepts utilisés dans la vaccination
- 2) Expliquer les différents paramètres utilisés pour l'estimation des besoins en vaccins et consommables
- 3) Citer les facteurs liés aux pertes de vaccins
- 4) Enumérer les étapes de l'estimation des besoins en vaccins et consommables à partir de la méthode de la population cible
- 5) Décrire le processus de commande des vaccins et consommables
- 6) Décrire le processus de Réception des vaccins et les consommables ;
- 7) Décrire la technique de rangement des vaccins et solvants dans un réfrigérateur vertical et horizontal
- 8) Décrire le mécanisme de Contrôle de la qualité des vaccins dans les lieux de stockage et aux postes de stratégie avancée
- 9) Enumérer les précautions à prendre pour sortir les vaccins pour la vaccination
- 10) Citer les techniques de calcul des taux d'abandon vaccinal

## **Intérêt du cours**

- ✓ Faiblesse dans la gestion des vaccins sur le terrain (surstock, ruptures ...)
- ✓ Perte en vaccins très élevée (destruction massive suite à la péremption, mauvais usage, PCV virée ...).
- ✓ Initiative d'indépendance vaccinale (financement de l'achat de vaccins par les pays).
- ✓ Coût de plus en plus élevé des vaccins.
- ✓ Nécessité d'une gestion optimale des vaccins.

# **I DEFINITION DES CONCEPTS**

## **1.1 Occasions manquées**

C'est une cible qui vient au centre pour une cause que la vaccination et qui sort du centre sans être vacciné alors qu'il l'aurait dû l'être.

## **1.2 Populations non atteintes ou hors de portée**

Ce sont les populations qui bien qu'ayant accès aux services de vaccination ne les utilisent pas pour des raisons informationnelles, culturelles, sociales ou financières...

## **1.3 Populations inaccessibles ou hors d'accès**

Ce sont les populations qui vivent loin des centres vaccinateurs ou qui vivent dans des endroits difficiles d'accès

## **1.4 Dose valide**

C'est une dose de n'importe quel antigène administré à l'âge recommandé dans l'intervalle de temps approprié.

## **1.5 Dose sacrifiée**

Ce sont les doses administrées aux populations hors cibles pour que la vaccination ait lieu.

## **1.6 Enfant correctement vacciné**

C'est l'enfant qui a reçu le nombre de vaccins et de doses conformément à, son âge et au calendrier de vaccination.

## **1.7 Enfant complètement vacciné**

C'est l'enfant qui a reçu toutes les doses des vaccins inscrit dans le calendrier de vaccination.

## **1.8 Enfant complètement et correctement vacciné**

C'est l'enfant qui a reçu toutes les doses de vaccins requis dans le respect du calendrier vaccinal prescrit

## **1.9 Abandon vaccinal**

Elle se définit comme toute cible qui a utilisé les services de vaccination et qui n'a pas complété sa vaccination

## II-PARAMETRES POUR L'ESTIMATION DES BESOINS EN VACCINS ET EN CONSOMMABLES

L'estimation des besoins en vaccin et consommables se fait selon trois méthodes qui sont :

- La méthode selon la consommation antérieure
- La méthode selon le nombre de séances de vaccination ;
- La méthode selon la population cible

La méthode que nous utilisons en Côte d'Ivoire pour l'estimation des besoins en vaccin et consommable et celle de la **population cible**. L'utilisation de celle-ci nécessite qu'un certain nombre de paramètres essentiels soient connus et définis au préalable à savoir :

- La population cible ; *pe*
- L'objectif vaccinal ; *DV*
- Le contact vaccinal ; *CV ou NC*
- Le facteur de perte. *FP*

### 2.1 La population cible

C'est une sous-partie de la population totale qui bénéficie de l'activité vaccinale. En Côte d'Ivoire, les populations cibles du PEV varient selon qu'on soit en vaccination de routine ou en campagne de vaccination.

Les populations cibles du PEV Ivoirien sont :

- Les enfants de 0 à 11 mois ; *0-23 19*
- Les femmes enceintes ;
- Les jeunes filles de 9 ans.

Tableau n°1 : Populations cibles du PEV et population cibles supplémentaires

| Population cible                   | Proportion                     | Activité vaccinale |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Enfant de 0 à 23 mois              | 6,82 % de la population totale | Routine.           |
| Femme enceinte                     | 5 % de la population totale    | Routine.           |
| Jeune fille de 9ans                | 1,86 % de la population totale | Routine            |
| <b>Pop cible supplémentaire</b>    |                                |                    |
| Enfant de 0 à 59 mois ou 0 à 5 ans | 20 % de la population totale   | Campagne (JNV)     |
| Femme en Age de Reproduction :     | 20 % de la population totale   | Campagne           |
| 9 ans à 13 ans                     | 6% de la population totale     | Campagne           |
| 9 mois à 14 ans                    | 45 % de la population totale   | Campagne           |

|                                  |        |  |
|----------------------------------|--------|--|
| <b>Autres cibles à connaître</b> |        |  |
| 0 à 6 mois                       | 1,45 % |  |
| 12 à 23 mois                     | 3,32%  |  |
| Femme séropositive               | 4,1 %  |  |
| 1 à 4 ans                        | 17,32% |  |

## 2.2 L'objectif vaccinal

L'objectif vaccinal est ce que l'on cherche à atteindre pour chaque antigène dans un programme de vaccination ou dans une activité vaccinale. Il varie selon le type de vaccin et l'activité vaccinale (vaccination de routine ou campagne de vaccination). L'objectif vaccinal doit être réaliste et fixé en fonction des priorités de la lutte contre la maladie.

**Tableau n°2 : Objectifs vaccinaux par antigène selon le type de vaccin appliqués en Côte d'Ivoire (DCPEV, 2022)**

| Antigènes                                     | Objectifs vaccinaux |             |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|
|                                               | En routine          | En campagne |
| BCG                                           | 95 %                |             |
| VPO                                           | 95 %                | 100%        |
| Vaccin anti Hépatite B pédiatrique            | 95 %                |             |
| VPI                                           | 95 %                |             |
| DTCHepHib (Pentavalent)                       | 95 %                |             |
| VAP                                           | 95%                 |             |
| RR (Rubéole, Rougeole)                        | 95 %                | 100%        |
| Rotarix                                       | 95 %                |             |
| PCV13                                         | 95 %                |             |
| VAA                                           | 95 %                |             |
| Td                                            | 95 %                | 100 %       |
| Vaccin contre le Papilloma Virus Humain (HPV) | 95 %                |             |
| Vaccin Antimeningococcique A                  | 95 %                | 100 %       |

## 2.3 Le contact vaccinal ou dose par cible

Un contact vaccinal est une dose d'un vaccin administrée à un sujet cible pour assurer sa protection. Le nombre de contacts vaccinaux annuels qu'il faut pour un sujet cible varie d'un vaccin à un autre et se détermine à partir du calendrier de vaccination en vigueur dans un pays.

**Tableau N°3 : Les contacts vaccinaux par antigène**

| Antigènes                                                                    | Nombre de contacts |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DN-Hépatite B                                                                | 1                  |
| BCG                                                                          | 1                  |
| DTC Hep Hib ou vaccin pentavalent                                            | 3                  |
| VAP                                                                          | 4                  |
| Rotarix                                                                      | 2                  |
| PCV13                                                                        | 3                  |
| VPO (Vaccin Polio Oral)                                                      | 4                  |
| VPI (vaccin Polio Inactivé)                                                  | 2                  |
| VAP                                                                          | 4                  |
| RR (Vaccin contre la rougeole et la Rubéole)                                 | 2                  |
| VAA (vaccin anti Amaril)                                                     | 1                  |
| Td (Vaccin contre le tétanos et la diphtérie)                                | 3                  |
| Vaccin Antimeningococcique A                                                 | 1                  |
| Vaccin contre le Papilloma virus humain (HPV)                                | 1                  |
| Vaccin contre le Papilloma virus humain pour jeune fille séropositive au VIH | 3                  |

#### 2.4 Le facteur de perte (FP)

C'est une perte en dose de vaccin due au conditionnement en flacons multidoses. Il se calcule à partir du **taux de perte** du vaccin.

**Tableau N°4 : Taux de perte par antigène**

| Antigènes                                     | Taux de perte - |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| BCG                                           | 40 %            |
| VPO                                           | 10 %            |
| Vaccin anti hépatite pédiatrique              | 10%             |
| DTC-HepB-Hib                                  | 10 %            |
| VAP                                           | ND              |
| VPI                                           | 10%             |
| Rotarix                                       | 5%              |
| PCV13                                         | 5%              |
| Td                                            | 10 %            |
| RR (vaccin contre la rougeole et la rubéole)  | 15 %            |
| Vaccin Anti Amaril                            | 15 %            |
| Vaccin Antimeningococcique A                  | 15%             |
| Vaccin contre le Papilloma virus humain (HPV) | 5%              |
| Seringues                                     | 10%             |

Tableau N°3 : Facteur de perte par antigène

| Antigènes                                     | Facteur de perte |
|-----------------------------------------------|------------------|
| BCG                                           | 1,66             |
| VPO                                           | 1,11             |
| Vaccin anti hépatite pédiatrique              | 1,11             |
| DTC-HepB-Hib                                  | 1,11             |
| VAP                                           | ND               |
| VPI                                           | 1,11             |
| Rotarix                                       | 1,05             |
| PCV13                                         | 1,05             |
| Td                                            | 1,11             |
| RR                                            | 1,17             |
| Vaccin Anti Amaril                            | 1,17             |
| Vaccin Antimeningococcique A                  | 1,17             |
| Vaccin contre le Papilloma virus humain (HPV) | 1,05             |
| Seringues                                     | 1,11             |

✓ Formule du calcul du taux de perte

Doses sorties - Doses administrées

$$TPertes = \frac{\text{Doses sorties} - \text{Doses administrées}}{\text{Doses sorties}} \times 100 \text{ ou } 100 - TU \text{ du vaccin}$$

✓ Formule du calcul du taux d'utilisation du vaccin (TU).

Nbre de doses effectivement administrées pendant une période donnée

$$TU = \frac{\text{Nbre de doses effectivement administrées pendant une période donnée}}{\text{Nbre de doses sorties pendant la même période}} \times 100$$

Ou  $TU = 100 - TPerte \text{ du vaccin}$

✓ Formule du calcul du facteur de perte

$$(Fpertes) = \frac{100}{100 - TPertes} = \frac{100}{100 - 15} = \frac{100}{85}$$

### III. FACTEURS LIÉS AUX PERTES DE VACCINS

#### 3.1 Facteurs évitables de perte de vaccins

- Mauvaise gestion des stocks entraînant un approvisionnement excédentaire et la péremption des vaccins avant leur utilisation ;
- Défaillance de la chaîne de froid exposant ainsi les vaccins à des températures extrêmement inacceptables (trop élevées ou trop basses) ;
- Administration des doses incorrectes. Par ex : l'administration de plus de trois gouttes de VPO au lieu de deux ;
- Perte, détérioration, casses ou vol des vaccins.
- Ces facteurs peuvent être améliorés par une bonne gestion des vaccins.

#### 3.2 Facteurs inévitables de perte de vaccins

- L'application de la politique du flacon entamé qui consiste à jeter les flacons de vaccins reconstitués 6 heures après leur reconstitution même si la température de conservation est normale.

### IV. ETAPES DE L'ESTIMATION DES BESOINS MENSUES ET ANNUELS EN VACCINS ET CONSOMMABLES

#### 4.1 Estimation des besoins mensuels et annuels en vaccin

##### 4.1.1 Besoin mensuel

$$\text{Besoin théorique (BT)} = \frac{\text{Pcible} \times \text{Objectif vaccinal} \times \text{Nbre de contact} \times \text{Fperte} \times \text{Période}}{12}$$

$$\text{Stock de sécurité (SS)} = \frac{\text{Besoin Théorique} \times 25}{100} \text{ pour les vaccins}$$

$$\text{Stock de sécurité (SS)} = \frac{\text{Besoin Théorique} \times 10}{100} \text{ pour les consommables}$$

$$\text{Besoin Réel (BR)} = \text{Besoin Théorique (BT)} + \text{Stock de Sécurité (SS)}$$

$$\text{Quantité à commander (QC)} = \text{Besoin Réel (BR)} - \text{Quantité en stock (QS)}$$

##### 4.1.2 Besoin annuel.

$$\text{Besoin annuel} = \text{Pcible} \times \text{Objectif vaccinal} \times \text{Nbre de contact} \times \text{Fperte}$$

#### 4.2 Estimation des besoins mensuels et annuels en consommables

L'estimation des besoins mensuels et annuels en consommables obéit à la même règle que celle des vaccins. Elle se fait à partir des mêmes paramètres que les vaccins.

**Seringue à injection** : Nombre de seringues à injection = Nombre de doses

**Seringue à dilution** : 1 seringue à dilution pour 1 flacon de vaccin à reconstituer

**Boîtes de sécurité** : la capacité est de 100 seringues

Le Besoin annuel de boîtes de sécurité = Besoin annuel de seringues / 100

Le besoin mensuel de boîtes de sécurité = Besoin annuel / 12

#### V.COMMANDE DE VACCINS

Après l'estimation des besoins en vaccin, il faut passer la commande. Cela consiste à :

- Faire l'inventaire de la quantité de vaccin en stock avant toute commande (fiche d'inventaire) ;
- Remplir la fiche de commande de vaccin (à retirer auprès du CPEV) en précisant la quantité à commander pour chaque antigène et la quantité en stock ;
- La commande des antigènes se fait sur le même bordereau de commande.

##### 5.1 Précautions à prendre pour la commande de vaccins

Toute commande de vaccins doit être faite en prenant des précautions suivantes :

- S'assurer que la capacité de stockage disponible est adéquate ;
- S'assurer que la conservation des vaccins est conforme aux normes recommandées ;
- S'assurer que les intrants nécessaires à la conservation (électricité, gaz stabilisateurs, groupe électrogène, outils de gestion) et à l'administration (diluants, seringues, BS, coton, outils de gestion...) sont commandés ou disponibles.

##### 5.2 Périodicité de commande de vaccins et consommables

| Niveau           | Période        |
|------------------|----------------|
| Dépôt central    | Chaque 6 mois  |
| Dépôts régionaux | Chaque 3 mois  |
| Dépôts districts | Chaque mois    |
| Centre de santé  | Chaque mois    |
| Case de santé    | Chaque semaine |

## VI. RECEPTION DES VACCINS ET CONSOMMABLES

Dès la réception des vaccins, il faut :

- S'assurer que la quantité sur le bordereau est conforme à la quantité reçue
- Vérifier les paramètres ci-dessous
  - Nom de l'antigène ;
  - Numéros de lot ;
  - Statut de la PCV ;
  - Date de péremption ;
  - Conditionnement ;
  - L'état des vaccins ;
  - Indicateur de monitoring de température.
- Remplir les fiches de stock pour chaque antigène tout en renseignant toutes les rubriques

## VII. RANGEMENT DES VACCINS ET DILUANTS

Le rangement des vaccins et diluants survient après leur réception. Il consiste à assurer aux vaccins les conditions de conservation requises (entre 2 et 8°C) pour ne pas rompre la chaîne de froid, assurant ainsi la qualité aux vaccins.

L'élément central dans le rangement des vaccins est le **réfrigérateur**. C'est pourquoi dès la réception et après vérification nécessaire, il faut immédiatement les ranger dans les réfrigérateurs en fonction de leur sensibilité à la lumière et de la congélation.

### 7.1 Les vaccins du PEV sensibles à la lumière.

- Le BCG,
- La Rubéole,
- La Rougeole-rubéole

Ces vaccins sont reconnaissables par leurs flacons teintés en noir.

### 7.2 Les Vaccins du PEV sensibles à la chaleur

- BCG;
- Penta;
- PCV13 ;
- RR ;
- Rotarix ;
- VAA;

Td;

▪ VPI ;

▪ VPO.

✓ *Ordre de Sensibilité de vaccin à la chaleur*

| Echelle                                                                           | Vaccins               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Très sensibles                                                                    | VPO                   |
|  | RR                    |
|                                                                                   | Penta+ VAA+VPI+ PCV13 |
|                                                                                   | BCG                   |
|                                                                                   | VAT/Td                |
| Moins sensibles                                                                   |                       |

**7.3 Les vaccins sensibles à la congélation**

- BCG, VAA, RR après reconstitution)
- DTC HepB ;
- HepB pédiatrique ;
- Hib liquide ;
- PCV13 ;
- Rotarix,
- VAT/Td ;
- VPI ;
- Vaccin contre le Papilloma virus humain.

✓ *Ordre de sensibilité à la congélation*

| Echelle                                                                             | Vaccins                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Très sensibles                                                                      | Hépatite B pédiatrique                         |
|  | Hib liquide                                    |
|                                                                                     | DTC, DTC-HepB +PENTA, PCV13                    |
|                                                                                     | VPI, Rotarix                                   |
|                                                                                     | VAT/Td ,Hib (lyophilisé),VAA,BCG et le diluant |
| Moins sensibles                                                                     |                                                |

#### 7.4 Rangement des vaccins et diluants dans un réfrigérateur (VERTICAL)

Le rangement de vaccins et diluants dans un réfrigérateur vertical doit obéir à certaines règles à savoir :

- Disposer les vaccins de sorte à avoir une bonne circulation de l'air ;
- Disposer les vaccins de sorte à permettre leur identification et une lecture rapide de la date de péremption ;
- Ranger les flacons entamés après les avoir marqués de couleur de sorte à les utiliser en premier lieu lors de la prochaine séance de vaccination selon la règle **Premier à Expirer Premier à Utiliser (PEPU)** ;
- Disposer les vaccins dans le réfrigérateur en respectant les règles **Premier à Périr Premier à Sortir (PPPS)** ;
- Ranger les vaccins sensibles à la chaleur dans le premier compartiment ou sur l'étagère supérieur, près du freezer (BCG, VAA, RR, etc.), et ceux sensibles à la congélation sur l'étagère du milieu, loin du compartiment congélateur (Td, vaccin contre le Papilloma virus humain, etc.) ;
- Ranger les diluants à l'étagère du bas ou compartiment du bas.

#### 7.5 Rangement dans un réfrigérateur horizontal ou Bahut

- Ranger les flacons de vaccins sensibles à la chaleur tels le vaccin contre la Rougeole-Rubéole, le VPO, le BCG, le vaccin Antiamaril au fond du réfrigérateur sur des accumulateurs de froid pour surélever les vaccins ;
- Ranger Les vaccins sensibles à la congélation comme la PCV13, le Rotarix, le penta, l'Hépatite B pédiatrique, Td, l'Hib, le vaccin Antimeningococcique A, le VPI, le vaccin contre le Papilloma virus humain au sommet (partie supérieure, loin du fond où ils peuvent être exposés à la congélation) ;
- Les diluants pour le vaccin contre le BCG, la RR la FJ se rangent également à côté des vaccins sensibles à la congélation.

#### 6 CAT en cas de flacons suspectés de congélation

- Si un flacon de vaccin liquide est suspecté de congélation, il faut :
- Prendre le flacon de vaccin suspecté de congélation et un autre non congelé du même vaccin et du même fabricant ;
- Agiter les deux flacons pendant au moins 5mn ;
- Laisser reposer les deux flacons pendant 15 à 20 minutes ;

- Comparez le flacon suspect avec le flacon test ;
- Si le vaccin congelé s'éclaircit et il n'y a pas de sédiment qui se dépose au fond du flacon, c'est qu'il est bon et il faut l'utiliser ;
- Si le vaccin congelé devient complètement clair et une épaisse couche de sédiment se forme au fond du flacon, c'est qu'il n'est pas bon et il ne faut pas l'utiliser.

## VIII. CONTROLE DE STOCK DE VACCINS

Plusieurs techniques permettent de contrôler l'efficacité des vaccins dans les lieux de stockage (réfrigérateur, chambre froide, etc.).

- Le relevé de la température du réfrigérateur.
- La pastille de contrôle de vaccins (PCV).

### 8.1 La politique du flacon entamé

C'est une technique de gestion des vaccins. Elle permet de réduire de façon substantielle les taux de pertes.

Elle consiste à réutiliser un flacon de vaccin liquide ouvert et duquel l'on a prélevé une ou plusieurs doses de vaccins pour la prochaine séance de vaccination **jusqu'à 4 semaines à condition que ce vaccin :**

- Ne soit pas périmé ;
- N'ait pas été contaminé (règles d'asepsie observées lors du prélèvement des doses) ;
- N'ait pas été exposé excessivement au froid ou à la chaleur excessive ;
- N'ait pas été immergés dans de l'eau ;
- Ne présente aucun trouble ou précipitation ;
- N'ait pas la PCV virée.

**La politique du flacon entamé s'applique uniquement aux vaccins multidoses liquides (VPO, Td, penta, PCV13, Rotarix, vaccin contre le Papilloma virus humaine).**

**Les vaccins reconstitués (BCG, RR, VAA et le vaccin contre la méningite) ne sont pas inclus dans la directive de la politique du flacon entamé, car ils ne doivent pas être conservés plus de 6 heures après leur reconstitution.**

## **IX PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LA SORTIE DE VACCINS**

Après rangement des vaccins. Certaines précautions doivent être observées pendant la sortie et le transport des vaccins aux postes de stratégie avancée.

### **9.1 Précautions à prendre pendant la sortie et transport des vaccins**

#### **9.1.1 Précautions pendant la sortie de vaccin du réfrigérateur**

- Tenir compte de la date de péremption du vaccin et non de sa date de réception ;
- Sortir en premier les vaccins dont le carré s'est assombri mais qui est toujours plus clair que le cercle ;
- Sortir en premier les vaccins liquides utilisés et ramenés dans le cadre de la politique du flacon entamé ;
- Eviter d'exposer pendant longtemps les vaccins à la chaleur et au froid selon leur sensibilité
- Refermer aussitôt la portière du réfrigérateur une fois la sortie des vaccins terminée

#### **9.1.2 Précaution pendant le transport du vaccin**

- Utiliser de préférence les accumulateurs de froid non congelés pour le transport des vaccins sensibles à la congélation (DTCHepB, Td, Hépatite B pédiatrique, le vaccin contre le Papilloma virus humain) ou isoler les vaccins en utilisant les sachets plastiques dans le cas où tous les accumulateurs sont congelés ;
- Utiliser les accumulateurs bien congelés pour le transport des vaccins VPO, RR, BCG, VAA ...);
- Eviter si possibles les secousses pour éviter de détériorer les vaccins ;
- Ne transporter les vaccins que dans les dispositifs adaptés et réservés à cet effet. (Glacière, porte vaccins etc.) ;
- Ne pas mettre des sachets d'eau congelée dans les glacières car une fois décongelés, ils pourront détruire la PCV.

## X. MECANISMES DE CALCUL DES TAUX D'ABANDON

### 10.1 Calcul des taux d'abandon

$$\text{Taux d'abandon Spécifique} = \frac{\text{DTCHepBHib1} - \text{DTCHepBHib3}}{\text{DTCHepBHib1}} \times 100$$

$$\text{Taux d'abandon Spécifique} = \frac{\text{Td1} - \text{Td 2}}{\text{Td1}} \times 100$$

$$\text{Taux d'abandon Global} = \frac{\text{DTC-HepB-Hib1} - \text{RR1}}{\text{DTC-HepB-Hib1}} \times 100$$

$$\text{Taux de couverture Spécifique} = \frac{\text{Nb de d'enfant ayant reçu le nombre de dose requis d'un antigène donné}}{\text{Population cible}} \times 100$$

$$\text{Taux de couverture vaccinale globale} = \frac{\text{Nb de d'enfant ayant reçu le nombre de dose requis de chaque vaccin}}{\text{Population cible}} \times 100$$

### 10.2 Causes possibles des abandons vaccinaux

- Vaccination non réalisée au quotidien ;
- Insuffisance de stratégies avancées ;
- Recherche active des perdus de vue non organisée ;
- Beaucoup d'occasions manquées de vaccination ;
- Faible niveau de communication ;
- Crainte d'un taux de perte élevé de vaccin (PF

### 10.3 Stratégies de réduction des abandons

- Rapprochement des services de vaccination des populations (plus de centres vaccineurs, postes avancés, stratégies avancées) ;
- Renforcement de la communication interpersonnelle et de la mobilisation sociale autour de la vaccination ;
- Renforcement de l'identification et de la recherche des enfants non vaccinés en y associant les agents de santé communautaire ;
- Mise à jour systématique et régulière des registres de vaccination ;
- Approvisionnement continu en vaccins et consommables.

## LE DIAGNOSTIC COMMUNAUTAIRE

### Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L2 de faire un diagnostic communautaire

### Objectifs spécifiques

Au terme de l'enseignement, il doit être capable de :

- 1) Définir les concepts de base du diagnostic communautaire
- 2) Enumérer au moins deux buts du diagnostic communautaire
- 3) Dégager l'importance du diagnostic communautaire dans un milieu de travail.
- 4) Expliquer les deux grandes approches utilisées dans le diagnostic com
- 5) Décrire la méthodologie utilisée dans le diagnostic communautaire
- 6) Décrire les critères de sélection d'un problème prioritaire
- 7) Enumérer les différentes étapes de la conduite d'un diagnostic communautaire.

## INTRODUCTION

Pendant longtemps, le système de santé est resté un système à part. L'on ne s'était nullement posé la question de ses articulations avec les autres systèmes qui constituent la vie des communautés humaines à savoir : le système économique, le système social, le système culturel et le système écologique, etc.

Il est maintenant démontré et évident pour tout le monde que le système sanitaire dépend étroitement des autres systèmes. C'est ainsi que pour être bien portant, tout individu doit manger à sa faim, consommer des aliments sains, etc. Seul le diagnostic communautaire, socle sur lequel devrait reposer toute politique de soins de santé primaires, permet à l'agent de santé d'acquérir une connaissance suffisamment fine des problèmes de la communauté et la manière dont ils sont perçus

## I. DEFINITIONS DES CONCEPTS DE BASE DU DIAGNOSTIC COM

### 1.1 Diagnostic

La définition du terme « diagnostic » au sens médical, correspond à l'identification d'une maladie par ses symptômes.

## 1.2 Diagnostic communautaire

Le diagnostic communautaire est un processus permettant de recueillir des informations d'ordre social, sanitaire, culturel, économique, démographique et politique sur une communauté afin d'identifier ses besoins en matière de santé et d'y apporter des solutions éventuelles avec sa pleine participation.

## II. BUTS DU DIAGNOSTIC COMMUNAUTAIRE

- Identifier les principaux problèmes de santé d'une communauté avec sa participation et ses ressources pour envisager les solutions et des actions ciblées sur les problèmes repérés ;
- Faire une analyse fine des ressources disponibles (matérielles et humaine) sur le plan quantitatif et qualitatif.
- Initier un processus de collaboration entre les populations et les agents de santé.

## III. IMPORTANCE DU DIAGNOSTIC COMMUNAUTAIRE

Le diagnostic communautaire

*diagnostic*

- Sert de base à toutes les actions sanitaires ;
- Permet d'orienter les efforts sur les besoins réels de la population ;
- Permet de renforcer les activités effectuées en santé communautaire, etc ;

## IV. APPROCHES UTILISEE DANS LE DIAGNOSTIC COMMUNAUTAIRE

Selon Raynald Pinault, deux grandes approches sont utilisées dans le diagnostic communautaire.

*manière de procéder en rapport avec la méthode*

### 4.1 L'approche basée sur la notion épidémiologique du besoin.

C'est une enquête épidémiologique dont l'objet est de collecter un maximum de données existantes sur l'état sanitaire de la population. Elle fournit les données quantitatives

### 4.2 L'approche psychosociologique des besoins

Elle permet de déterminer les perceptions de la population relatives aux problèmes de santé rencontrés dans le milieu et les moyens de résolution de ces problèmes. Elle fournit les données qualitatives.

## V. METHODOLOGIE UTILISEE DANS LE DIAGNOSTIC COM

### 5.1 La phase préparatoire :

#### 5.1.1 L'implication communautaire

- Impliquer la communauté et les autres professionnels concernés. (Il faut éviter de mettre la communauté et ses représentants devant le fait accompli et lui proposer de participer à un projet déjà élaboré en dehors d'elle.)
- Constituer un groupe de travail qui rassemblera toutes les couches socio professionnelles du milieu. Ce groupe de travail déterminera les étapes successives à suivre, définira les objectifs de l'étude, les moyens et les méthodes et mobilisera les ressources nécessaires.

#### 5.1.2 La préparation technique

Elle consiste d'une part à informer et d'autre part à former les personnes directement impliquées dans le diagnostic communautaire.

### 5.2 Le diagnostic communautaire proprement dit

#### 5.2.1 Définition des objectifs

Il s'agit de se mettre d'accord sur ce que l'on cherche à obtenir, dans quel but et auprès de quelles communautés.

#### 5.2.2 Informations ou données à recueillir

Elles sont en rapport avec les caractéristiques de la communauté et les relations caractéristiques, état de santé de la communauté.

##### ✓ Au niveau de l'environnement général de la communauté

- Dans quelle région est implanté le village ?
- Quelles sont les différentes saisons ?
- Quels sont les types de végétation, de climat ?
- De quel centre administratif dépend le village, Etc. ?

##### ✓ Au niveau du village

- Quelle est l'histoire du village ;
- Le village est-il loti ?
- Quelle est la proportion de maisons en dur ?
- Faire un plan orienté du village avec les routes, les pistes les différents quartiers, le marché etc.) ;

✓ *Au niveau démographique*

- Le nombre d'habitants, de familles, de ménages ;
- Les mouvements migratoires de cette population ;
- Les différentes ethnies rencontrées ;
- Les différentes personnes influentes du village (notables, chefs religieux, autorités politiques etc.)

✓ *Au niveau Economique*

- Quelles sont les ressources financières du village ? culture, pêche, élevage, artisanat etc. ;
- L'usage des produits récoltés (consommation, vente) ;
- Quels sont les débouchés possibles ? ya-t-il un marché sur place ? Quel jour a-t-il lieu ? Quels sont les marchés voisins les plus importants ?
- Existe-il des fonctionnaires, des GVC, des coopératives, des moyens de communication, des associations à bases communautaires ? etc.

✓ *Au niveau socio culturel*

- Ya-t-il des coutumes ? des traditions ? des fêtes propres au village ou à la région ?
- Quels sont les jours de repos ?
- Existe-t-il des associations culturelles, politiques et religieuses ?
- Quelles sont les différentes ethnies et religions rencontrées ? Etc.

✓ *Au niveau sanitaire*

- Existe-t-il des problèmes de santé liés à l'alimentation, à l'eau ?
- Existe-t-il des pratiques de la prostitution, etc. ;
- Quels sont les structures et équipements sanitaires existants (privés et publics) ?
- Où accouchent les femmes ? (Centre de santé ou domicile), etc.

### 5.2.3 Identification des sources de données, choix des méthodes, élaboration d'instruments de recueil des données

#### ❖ Identification des sources possibles

Les sources sont de deux ordres :

- Les informations existantes ;
- Les formations à rechercher.

#### ✓ *Les informations existantes*

Le plan de développement socio-économique et sanitaire du pays ;

- Les registres d'état civil ;
- Les registres de consultation ;
- Les statistiques sanitaires et démographiques ;
- Les rapports d'activités des services de santé, Etc ;

#### ✓ *Les informations à rechercher*

Elles correspondent à ce que l'on a appelé l'approche psychosociale des besoins et des problèmes.

#### ❖ Choix des méthodes

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées :

#### ✓ *Méthodes non systématiques*

- L'observation ;
- Les interviews ;
- Les réunions de groupe ;
- Les visites.

#### ✓ *Méthodes systématiques*

Ce sont les enquêtes systématiques de type épidémiologique. Elles consistent à rechercher de facteurs de risque ou les causes des comportements. Elles permettent de recueillir des données précises, quantifiables sur la communauté afin de confirmer et compléter les informations mises en évidence ou soupçonnées par les méthodes non systématiques.

#### 5.2.4 Elaboration des instruments de recueil de données

Le recueil de données se fait à l'aide d'outils ou instruments de collecte préalablement élaborés et tenant compte des informations à recueillir. Ces outils peuvent être :

- Un questionnaire ;
- Un guide d'entretien ;
- Une grille d'observation ;
- Une fiche d'inventaire, etc.

#### 5.2.5 L'analyse et l'interprétation des données

Elle permet de compiler, trier, recouper et classer les données collectées. En tant que personnel de santé, l'on cherchera à mesurer l'impact des facteurs qui déterminent l'état de santé. (Alimentation, assainissement, etc.)

### VI. ETAPES DE LA CONDUITE DU DIAGNOSTIC COMMUNAUTAIRE

1. Identification des problèmes, des besoins et des ressources ;
2. Etablissement des priorités ;
3. Documentation des problèmes prioritaires ;
4. Définition des objectifs d'action ;
5. Choix des stratégies ;
6. Mise en place d'un plan d'action ;
  - Choix des activités ;
  - Mobilisation et coordination des ressources ;
7. Mise en œuvre des activités.
8. Mise en place d'un plan d'évaluation

8 étapes  
diagnostic

### VII CRITERES DE SELECTION DE PROBLEME PRIORITAIRE (6 critères)

1. La population cible touchée par le problème ;
2. L'ampleur du problème (le nombre de cas) ;
3. La gravité du problème (le nombre de décès ou de séquelles) ;
4. La vulnérabilité du problème (existence de mesures de contrôle efficaces)
5. Perception du problème par la population (la population perçoit-elle le problème de la même façon que l'agent de santé ?) ;
6. Coûts des interventions.

6 critères

## 7.1 Pondération des différents critères de sélection d'un problème prioritaire

### 7.1.1 Population-cible

- Enfants, femmes enceintes : 05 points
- Vieillards, adultes : 02 points

### 7.1.2 L'ampleur du problème

- < à 10 cas : 02 points
- Entre 10 à 19 cas : 04 points
- 20 cas et plus : 05 points

### 7.1.3 La gravité du problème

- Ne constitue aucune menace : 0 point
- < 4 décès ou séquelles : 02 points
- Entre 5 et 14 décès ou séquelles : 04 points
- 15 décès ou séquelles et plus : 05 points

### 7.1.4 La vulnérabilité

- Une solution existe : 05 points
- La solution est acceptable : 01 point
- La solution est réalisable : 01 point
- La solution est applicable : 01 point

### 7.1.5 La perception du problème par la population.

- La population a une bonne perception du problème : 05 points ;
- La population a une perception erronée du problème : 02 points

### 7.1.6 Le coût des interventions

- Le coût est-il à la portée de la population : 05 points ;
- Le coût nécessite-t-il l'appui d'une ONG : 03 points ;

### Exemple de tableau pour la sélection d'un problème prioritaire

| Critères<br>Problèmes | Pop<br>Cible | Ampleur du<br>problème | Gravité<br>du problème | Vulnérabilité | Perception du<br>problème | Coût de<br>l'intervention | Total |
|-----------------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-------|
|                       |              |                        |                        |               |                           |                           |       |
|                       |              |                        |                        |               |                           |                           |       |
|                       |              |                        |                        |               |                           |                           |       |

### Exemple de plan d'action

| Activités | Période | Lieu | Bénéficiaires<br>Cibles | Responsable<br>s d'exécution | Ressources  |             |          | Observation |
|-----------|---------|------|-------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|
|           |         |      |                         |                              | Financières | Matérielles | Humaines |             |
|           |         |      |                         |                              |             |             |          |             |

### Exemple de plan d'évaluation

|             |                    |  |
|-------------|--------------------|--|
| Qui ?       | Personnel          |  |
| Que         | Critères /Objectif |  |
| Quoi        | Activités          |  |
| Où ?        | Lieu               |  |
| Quand ?     | Période            |  |
| Comment ?   | Méthode            |  |
| Avec quoi ? | Instrument         |  |

## CONCLUSION

Le diagnostic communautaire est une étape indispensable pour tout projet en santé communautaire. Il permet d'analyser les informations collectées dans la communauté et d'initier la participation de la communauté et le changement de comportement.

## LES FLEAUX SOCIAUX

### Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la licence 2 d'assurer la prévention des fléaux sociaux

### Objectifs spécifiques

A la fin du cours, il doit être capable de ;

- 1) Définir les termes liés aux fléaux sociaux
- 2) Décrire les différents fléaux sociaux

### INTRODUCTION

Avec les progrès scientifiques, d'importants changements ont lieu dans la répartition des causes de morbidité et de mortalité. Ainsi, les taux de morbidité et de mortalité des maladies infectieuses ont baissé. Par contre, ceux des maladies non infectieuses ont connu une ascendance.

Selon l'OMS (2018), les maladies non transmissibles tuent chaque année 71 millions de personnes dans le monde.

### I DEFINITIONS DES TERMES LIES AUX FLEAUX SOCIAUX

#### ✓ **Stupéfiant**

C'est une substance psychotrope dont l'usage répété conduit à une dépendance

#### ✓ **Accoutumance**

C'est un phénomène par lequel l'organisme devient peu à peu insensible à un produit régulièrement absorbé et qui oblige souvent le toxicomane à augmenter les doses.

#### ✓ **Pharmacodépendance**

C'est un état résultant de l'absorption périodique ou continue de certaines substances chimiques.

#### ✓ **Dépendance**

C'est un état résultant de l'absorption continue et répétée de drogue ou leurs dérivés. Cette dépendance se manifeste par un besoin excessif de la drogue ou certains médicaments.

### ✓ **Tolérance**

C'est la propriété que possède l'organisme de supporter des doses d'une substance sans manifester des signes d'intoxication.

### ✓ **Toxicomanie**

C'est un état d'intoxication périodique ou chronique nuisible à l'individu et à la société engendré par la consommation d'une drogue naturelle ou synthétique.

## **II DESCRIPTION DES DIFFERENTS FLEAUX SOCIAUX**

### **2.1 ALCOOLISME**

#### **2.1.1 Définition**

C'est un ensemble de phénomènes pathologiques entraîné par l'abus de boissons alcoolisées.

#### **2.1.2 Profil épidémiologique**

L'alcool est sans doute la drogue la plus disponible et accessible dans le monde entier. L'OMS estime entre 5 et 6 millions le nombre de personnes qui auraient eu une consommation d'alcool à risque, favorisant la dépendance. Le nombre des alcool dépendants est estimés à environ 2 millions

#### **2.1.3 Facteurs favorisant l'alcoolisme**

- Facteurs émanant de la personne. (Les personnes timides ou angoissées...);
- Facteurs liés au milieu social (environnement familial et professionnel...)
- Facteurs liés aux conditions de vie (Le chômage...)
- Facteurs économiques (alcool source de revenu pour certains pays...)

#### **2.1.4 Effets de l'alcool sur la santé**

- ✓ **Effets aigus :** Ils se manifestent au début par un ralentissement des réflexes jusqu'au coma avec ralentissement des rythmes cardiaques et respiratoires
- ✓ **Effets chroniques :** Ils s'observent au niveau de l'appareil digestif (gastrite aigue...), du système nerveux (polynévrite...), de l'appareil cardio-vasculaire (cardiopathie...), de l'appareil respiratoire (bronchite...) et de la conscience (baisse de la vigilance...)

### 2.1.5 Mesures préventives de l'alcoolisme

- Mesures limitant la consommation. (Interdire la vente de l'alcool devant et à l'intérieur des écoles, des hôpitaux et marchés, etc.)
- Actions répressives. (Réprimer l'ivresse publique...)
- Actions médico-sociales. (Dépister précocement les buveurs excessifs et assurer la prise en charges dans les centres spécialisés, lutter contre le chômage, la pauvreté...)
- Sensibiliser et éduquer les populations sur les méfaits de l'alcool notamment les groupes à risque. (Les femmes, les jeunes, les ouvriers des entreprises, etc.)

## 2.2 LA DROGUE

### 2.2.1 Définition

C'est un produit (ou) une substance d'origine animale ou chimique utilisé comme ingrédient dans une préparation médicamenteuse.

### 2.2.2 Profil épidémiologique.

L'OMS estime le nombre de consommateurs réguliers de cannabis à 850 000 dont 450 000 usagers quotidiens. A 18 ans, un garçon sur cinq fume quotidiennement du cannabis, tandis que 53 % des garçons et 47,2 % des filles de moins de 17 ans l'ont déjà expérimenté.

### 2.2.3 Problèmes socio-sanitaires causés par l'abus des drogues

#### ✓ Problèmes sociaux

- L'absentéisme ;
- Les accidents de la voie publique ;
- Le suicide, etc.

#### ✓ Problèmes sanitaires

- L'hallucination ;
- Le délire ;
- L'asthénie, etc.
- Hématome retro placentaire chez la gestante qui consomme de la drogue pendant la grossesse par exemple

## 2.2.4 Moyens de lutte contre la drogue

- Limitation de l'accès aux drogues par des mesures de contrôle du trafic et de répression de la distribution et de la consommation ;
- Identification et suppression des facteurs environnementaux qui exposent à la toxicomanie ;
- Sensibilisation de la population en général et la jeunesse en particulier sur les dangers sanitaires de la drogue.
- Mobilisation de toutes les couches sociales contre la consommation de la drogue
- Association des autres secteurs d'activités aux actions de lutte dans une approche multisectorielle (Ministère en charge de la santé, de la Justice, de la Communication) pour l'efficacité de la lutte

## 2.3 LE TABAGISME

### 2.3.1 Définition

Selon le dictionnaire Petit Robert, le tabagisme est un ensemble de troubles physiologiques et psychiques provoqués par l'abus du tabac.

### 2.3.2 Profil épidémiologique

L'OMS estime à au moins 3,5 millions de décès annuels dus au tabagisme dans le monde dont environ 2 millions dans les pays développés. L'incidence annuelle du cancer causé par la consommation du tabac est de 1,5 millions de nouveaux cas de cancer par an dans le monde. Le tabac constitue la principale cause de mort évitable.

### 2.3.3 Facteurs favorisant le tabagisme

- Difficultés psychologiques ;
- Les difficultés familiales ;
- Les campagnes publicitaires menées par les industriels, etc.

### 2.3.4 Moyens de lutte contre le tabagisme

- Sensibilisation des fumeurs sur les dangers de la cigarette ;
- Création des structures de prise en charge des jeunes et personnes en difficulté ;
- Réglementation de la publicité sur le tabac ;
- Interdiction du parrainage de certaines usines de tabac en faveur de certains jeux ou sports rassemblant la jeunesse ;
- Initiation de plaidoyer auprès des Etats pour ratifier la convention cadre pour la lutte anti-tabac adoptée en Genève en 2003

## **SURVEILLANCE INTEGREE DE LA MALADIE ET RIPOSTE (SIMR)**

### **Objectif général**

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la Licence 2 d'effectuer la surveillance intégrée des maladies et d'organiser la riposte

### **1.2 Objectifs spécifiques**

A la fin du cours il doit être capable de :

- 1) Définir le concept "surveillance intégrée de la maladie et riposte" (SIMR)
- 2) Citer les objectifs de la SIMR
- 3) Citer les maladies prioritaires sous surveillance
- 4) Définir les cas de maladie sous surveillance pour la notification

### **INTRODUCTION**

Au cours de la décennie passée, le monde et singulièrement la région Africaine de l'Organisation Mondiale de Santé a dû faire face à plusieurs épidémies de choléra, de méningite à méningocoques, de typhoïde et de grippe, entre autres, et plus récemment, à une épidémie de la maladie à virus Ebola et à la maladie à coronavirus avec des taux de morbidité et de mortalité très élevés. Il est établi que les pays dont les systèmes de surveillance sont peu performants ne sont pas à mesure de détecter les menaces pour la santé publique ou les événements de santé publique et d'y répondre à temps voulu.

La surveillance est définie comme le recueil systématique et continu des données sanitaires, leur analyse et leur interprétation pour l'action c'est-à-dire la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des pratiques de santé publique

En Côte d'Ivoire, plusieurs maladies sont sous surveillance (**52 maladies**). Dans ce chapitre, nous décrirons que quelques-unes. Il s'agit :

- ✓ La Paralysie Flasque Aigue (PFA)
- ✓ La Poliomyélite due à un poliovirus de type sauvage
- ✓ La poliomyélite due à un poliovirus dérivé d'une souche vaccinale
- ✓ Le Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS)
- ✓ La rougeole
- ✓ La fièvre jaune
- ✓ Le tétanos néonatal
- ✓ La maladie à coronavirus ou COVID-19

## I DEFINITIONS

### 1.1 Surveillance

La surveillance est le « processus de collecte systématique, organisé et continu de données de santé ainsi que leur analyse, interprétation et dissémination dans une perspective d'aide à la décision et d'évaluation. »

### 1.2 Surveillance intégrée de la maladie et riposte

La Surveillance intégrée de la maladie et réponse (SIMR) est une stratégie adoptée par les pays de la Région africaine de l'OMS pour mettre en œuvre des systèmes complets de surveillance de la santé publique et de riposte pour les maladies, affections et événements prioritaires à tous les niveaux notamment au niveau communautaire et national ....(Guide technique pour la surveillance intégrée de la maladie et la riposte dans la région africaine, 2019)

## II. OBJECTIFS DE LA SIMR

- Surveiller les tendances des maladies ;
- Détecter précocement des situations inhabituelles ;
- Faciliter la réponse fondée sur des bases factuelles.

## III. LES MALADIES PRIORITAIRES SOUS SURVEILLANCE

- Les maladies à potentiel épidémique (le choléra, la grippe, la méningite à pneumocoque, la fièvre hémorragique virale, la COVID-19).
- Les maladies faisant l'objet de mesure d'élimination et d'éradication (la poliomyélite à poliovirus sauvage, ver de guinée etc.)
- Les maladies cibles du Programme Elargi de vaccination (PFA, rougeole, fièvre jaune, tétanos néonatal, etc.)

parce qu'il y a  
flasque  
d'urgence

#### IV. DEFINITIONS DE CAS DE MALADIE SOUS SURVEILLANCE POUR NOTIFICATION

##### 4.1 LA PARALYSIE FLASQUE AIGUE (PFA)

###### 4.1.1 Définition de cas pour notification

###### ✓ Au niveau de la structure sanitaire

C'est tout enfant présentant une faiblesse ou une diminution ou une perte du tonus musculaire touchant n'importe quel muscle du corps, principalement les muscles des bras et/ou des jambes et survenant de façon brutale.

###### ✓ Au niveau communautaire

C'est tout enfant chez qui l'on note une apparition soudaine d'une maladie paralytique aigue.

###### 4.1.2 Gestes à faire devant un cas de PFA

- Notifier immédiatement le cas aux autorités sanitaires du district;
- Recueillir 2 échantillons de selles (8-10g) à un intervalle d'au moins 24-48 heures, dans les 14 jours après l'apparition de la paralysie ;
- Embaquer suffisamment les échantillons de selles dans un récipient en matière plastique propre, étanche et fermé par couvercle à vis et l'expédier dans un porte vaccin entre +2°C à + 8°C vers les services compétents ;
- Acheminer les échantillons en bon état au laboratoire de l'Institut Pasteur dans un délai de 3 jours après collection. *soit 72h*

Tableau récapitulatif des activités urgentes à mener et les délais d'exécution devant un cas de PFA

| Activités à mener                                 | Délai de prélèvement |                  |                      |           |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------|
|                                                   | Entre J0 et J14      | Entre J14 et J60 | Entre J61 et 06 mois | > 06 mois |
| Prélèvement de selles                             | X                    | x                |                      |           |
| Notification avec diagnostic provisoire           | X                    | x                | X                    |           |
| Investigation avec fiche                          | X                    | x                | X                    |           |
| Inscription du code EPID dans la Base PFA         | X                    | x                | X                    |           |
| Examen du 60eme jour                              |                      | x                |                      |           |
| Inscription sur la liste linéaire dans base Excel |                      |                  |                      | x         |
| Classification par le CNEP                        |                      | x                | X                    | x         |
| Analyse et actions correctrices                   |                      | x                | X                    | x         |

#### 4.1.3 Indicateurs de surveillance des PFA

La surveillance épidémiologique de la PFA est efficace dans un district sanitaire ou un pays si et seulement si :

- ✓ Le taux de PFA est dit non poliomyélitique lorsque le nombre de cas de PFA est  $\geq 2$  pour 100 000 enfants de moins de 15 ans
- ✓ La proportion d'échantillons de selles prélevés dans les 14 jours après le début de la paralysie doit être  $\geq 80\%$

### 4.2 LA POLIOMYELITIS DUE A UN POLIOVIRUS DE TYPE SAUVAGE

#### 4.2.1 Définition de cas pour la notification de la poliomyélite due à un virus de type sauvage

En vertu du règlement sanitaire international (RSI) 2005, un cas de poliomyélite due à un poliovirus de type sauvage qui doit être notifié est défini comme un cas présumé ou un poliovirus sauvage ayant été isolé dans les échantillons de selles de ce cas ou dans ceux d'un de ces contacts proches.

#### 4.2.2 Définition de cas présumé

Un cas présumé est tout enfant de moins de 15 ans présentant une paralysie flasque aiguë ou toute personne quel que soit son âge présentant une maladie paralytique et chez qui l'on soupçonne une poliomyélite.

#### 4.2.4 Procédure standard pour le recueil des selles selon le RSI

Elle consiste à recueillir deux (02) échantillons de selles d'un cas de PFA dans les 14 jours suivant l'apparition de la paralysie. Comme l'excrétion virale dans les selles diminue au-delà de deux semaines après le début de la paralysie, pour accroître la sensibilité de la détection virale, des échantillons de selles supplémentaires provenant de cinq contacts proches sont prélevés pour les cas de PFA pour lesquels on ne dispose pas de deux échantillons de selles recueillis dans les 14 jours suivant l'apparition de la paralysie.

### 4.3 LA poliomyélite due à un poliovirus dérivé d'une souche vaccinale (pvdvc)

Le vaccin anti poliomyélite oral (VPO) contient une forme atténuée (affaiblie) du poliovirus qui active une réponse immunitaire de l'organisme.

Quand le VPO est administré à un enfant, la souche vaccinale affaiblie se replie dans l'intestin pour une période limitée, ce qui lui permet de développer son immunité en synthétisant des anticorps. Pendant ce temps de synthèse d'anticorps, la souche vaccinale est également excrétée, et dans les zones où l'assainissement de l'environnement est insuffisant, ces virus vaccinaux peuvent se propager dans la communauté à d'autres enfants par le biais de l'immunité passive avant de finir par s'éteindre.

Mais il arrive de temps en temps, dans les communautés ayant une très faible immunité, que la souche vaccinale excrétée puisse continuer de circuler sur une durée prolongée et peut à la longue subir de mutation génétique et devenir un poliovirus circulant dérivé d'une souche vaccinale capable de provoquer une paralysie (PVDVc)

### **4.3 SYNDROME RESPIRATOIRE AIGUE SEVERE (SRAS)**

#### **4.3.1 Définition de cas pour la notification du SRAS**

En vertu du RSI (2005), dans la période qui suit une flambée du SRAS, un cas de SRAS qui doit être notifié est défini comme étant le cas d'un sujet présentant une confirmation au laboratoire d'une infection par le coronavirus du SRAS qui, soit correspond à la définition clinique du cas de SRAS, soit a travaillé dans un laboratoire manipulant des coronavirus du SRAS vivant ou conservant des échantillons infectés par le coronavirus du SRAS

#### **4.3.2 Définition d'un cas clinique SRAS**

Un cas de SRAS clinique est défini chez toute personne présentant :

Des antécédents de fièvre ou une fièvre documentée

Et

Un ou plusieurs symptômes d'une affection des voies respiratoires inférieures (toux, difficulté respiratoire, essoufflement)

Et

Des signes radiographiques d'une pneumonie ou d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), ou des résultats d'autopsie correspondant à la pneumonie ou du SDRA sans qu'il ait de cause identifiable

Et

Aucun autre diagnostic ne pouvant expliquer la maladie

## 4.4 LA ROUGEOLE

### 4.4.1 Définition de cas pour la notification

#### ✓ Au niveau de la structure sanitaire

##### ↓ Cas suspect de rougeole

C'est est un enfant présentant une Fièvre, une éruption, une toux ou un coryza ou une conjonctivite ou toute personne chez qui un clinicien suspecte la rougeole.

##### ↓ Cas confirmé de rougeole

C'est un cas suspect avec IgM positif ou cas suspect avec notion de contact physique avec un cas confirmé (lien épidémiologique) dans les jours ayant précédé le début de la maladie ou cas suspect confirmé cliniquement.

#### ✓ Au niveau communautaire

C'est toute personne présentant une chaleur corporelle et une éruption cutanée étendue sur le visage et le corps.

### 4.4.2 Définition de Suspicion et de confirmation d'une épidémie

#### ✓ Suspicion d'une épidémie

C'est lorsque cinq (05) cas suspects ou plus sont notifiés en un mois au sein d'une population de 100 000 habitants vivants dans un district sanitaire ou une aire de santé.

#### ✓ Confirmation d'une épidémie

C'est lorsque trois (03) cas confirmés ou plus sont notifiés en un mois au sein d'une population de 100 000 habitants vivants dans un district sanitaire ou une aire de santé avec notion de lien épidémiologique.

### 4.4.3 Organisation de la riposte devant un cas suspect de rougeole.

- Prélever le sang entre le 4<sup>ème</sup> et le 28<sup>ème</sup> jour après le début de l'éruption ;
- Laisser décanter dans un porte vaccin où sont disposés des accumulateurs congelés (+2 et + 8) ;
- Recueillir le sérum dans un autre tube ;
- Remplir le formulaire générique de notification des cas en précisant :
  - Nom & prénoms ;
  - Age ;
  - Statut vaccinal ;
  - Date du début de l'éruption ;

- Date de collecte ;
- Provenance ;
- Formulaire d'enquête dûment rempli ;
- Résidence au moment de l'éruption,
- Ranger le prélèvement dans un porte vaccin ;
- Disposer d'accumulateurs bien congelés tout autour ;
- Fermer le porte vaccin ;
- Accompagner le prélèvement de la fiche d'enquête ;
- Acheminer le porte vaccin au district sanitaire ou à la DCPEV.

NB : Faire un prélèvement de gorge des cas entre J1 à J7.

#### 4.4.3 Mesures préventives

- ✓ Limiter l'extension de la PEC des cas et contacts :
  - *Si cas suspect* : Traitement adéquat et limitation de contact entre sujets vaccinés et sujet ayant fait maladie.
  - *Si cas confirmé* : Hospitalisation, traitement adéquat, limitation de contact entre sujets vaccinés et ayant fait la maladie.
  - *Si sujet contact* : Vaccination, Isolement dès apparition des 1<sup>ers</sup> signes.
- ✓ Vacciner tout cas suspect de rougeole (vaccination sélective)

## 4.5 FIEVRE JAUNE

### 4.5 Définition de cas pour notification

#### 4.5.1 Au niveau de la formation sanitaire

##### ✓ Cas suspect :

C'est tout sujet présentant une fièvre d'apparition brusque avec ictère apparaissant dans les 14 jours après le début des symptômes.

##### ✓ Cas probable :

C'est tout cas suspect IgM avec histopathologie du foie positive ou lien épidémiologique avec un cas confirmé chez un sujet non vacciné dans les 30 jours

##### ✓ Cas confirmé

C'est tout cas probable positif à la recherche d'anticorps spécifique IgM et IgM négatif aux autres flavivirus ou augmentation du titre IgM ou IgG par 4 ou détection d'anticorps neutralisants spécifiques chez un sujet non vacciné dans les 30 jours

#### 4.5.2 Au niveau communautaire

C'est toute personne présentant un jaunissement soudain de la peau de plus de deux semaines, avec ou sans chaleur corporelle.

#### 4.5.3 Définition d'une épidémie de Fièvre Jaune

Il ya épidémie de fièvre jaune lorsqu''au moins un cas suspect est confirmé au laboratoire.

#### 4.5.4 Gestes à faire devant un cas suspect de fièvre jaune

- Entreprendre une investigation clinique, épidémiologique et entomologique
- Identifier la zone concernée et les personnes à risque
- Organiser une vaccination de masse réactive selon les conclusions de l'investigation
- Initier des mesures de lutte anti vectorielle

## 4.6 TETANOS NEONATAL

### 4.6.1 Définition de cas pour la notification

#### ✓ Cas suspect

C'est tout cas de décès néonatal survenu entre le 3<sup>ème</sup> et le 28<sup>ème</sup> jour de la vie et dont la cause est inconnue ou tout nouveau-né ayant souffert ou signalé avoir souffert du tétanos entre le 3<sup>ème</sup> et le 28<sup>ème</sup> jour de la vie mais n'ayant pas fait l'objet d'une enquête.

#### ✓ Cas confirmé

C'est tout nouveau-né ayant présenté une aptitude normale à téter et à crier pendant les 2 premiers jours de la vie et ne pouvant plus téter normalement entre le 3<sup>ème</sup> et le 28<sup>ème</sup> jour ou tout nouveau-né qui devient raide et/ou a des convulsions.

**NB :** La classification des cas de tétanos néonatal est purement clinique et ne dépend pas d'une confirmation du laboratoire.

### 4.6.2 Éléments clés à rechercher au cours de l'investigation devant un cas de tétanos néonatal

- Statut vaccinal de la mère ;
- Nombre et dates des consultations prénatales ;
- Lieu accouchement (CHU, CHR, HG, maternité, domicile) ;
- Responsable de l'accouchement (personnel de santé, accoucheuse traditionnelle formée ou non, autre...) ;
- Cordon ombilical : état des instruments utilisés pour section, pansement à domicile ? utilisation de produits traditionnels ?
- Évolution du cas (décédé, vivant, inconnu) ;
- Réponse au cas (décrire les actions menées).

### 4.6.3 Gestes à faire devant un cas de tétanos néonatal

- Notifier sans tarder au district sanitaire ou à la DCPEV ;
- Pas de prélèvement à faire ;
- Référer le cas à l'hôpital du district pour une prise en charge ;
- Investiguer pour identifier les facteurs associés à la survenue du cas (cas et communauté.
- Si cas confirmé après investigation

- Administrer à la mère du malade et aux autres femmes et filles vivant dans la même habitation que le cas, 2 doses du vaccin antitétanique à l'intervalle d'un mois ;
- Organiser dans la localité des activités de vaccination supplémentaire en deux (02) passages à l'intention de toutes les Femmes en âge de reproduction (FAR) plus riposte (avec rapport) ;
- Eduquer les femmes en âge de reproduction quant à la nécessité de couper et de soigner le cordon en observant de bonnes conditions d'hygiène.
- Améliorer la couverture vaccinale de routine du Td.

## 4.7 LA MALADIE A CORONAVIRUS OU COVID-19

### 4.7.1 Définition de cas pour notification

#### ✓ Cas suspect de COVID-19

A. C'est une personne qui remplit les critères cliniques Et épidémiologiques

##### ▪ Critères cliniques

- Apparition soudaine de fièvre ET de toux ;  
OU
- Apparition soudaine d'au moins trois des signes suivants : Fièvre, toux, faiblesse/fatigue générale, céphalée, myalgie, mal de gorge, coryza, dyspnée, anorexie/nausées/vomissements, diarrhée, altération de l'état mental.

##### ▪ Critères épidémiologiques

Séjour ou travail dans une zone à haut risque de transmission du virus (Établissements résidentiels clos, camps ou centre d'accueil pour les personnes déplacées) à tout moment au cours des 14 jours précédents l'apparition des symptômes.

OU

Séjour ou voyage dans une zone de transmission communautaire à tout au cours des 14 précédents l'apparition des symptômes

OU

Travaille dans le secteur de soins de santé, y compris dans les établissements de santé ou dans la communauté, à tout moment au cours des 14 jours précédents l'apparition des symptômes

B. C'est un patient présentant une infection une infection respiratoire aigüe sévère (IRAS-infection respiratoire aigüe en présence d'antécédents de fièvre ou d'une fièvre mesurée supérieur ou égale à 38 degrés et de toux, apparue au cours des 10 derniers et nécessitant une hospitalisation.

#### ✓ Cas probable de COVID-19

A./ C'est un patient qui remplit les critères cliniques ci-dessus ET qui a été en contact avec un cas confirmé ou probable de COVID-19 ou qui a été relié sur le plan épidémiologique à un groupe de cas dans lequel il ya eu au moins un cas confirmé

**B./ C'est un cas suspect pour lequel une imagerie thoracique révèle des observations indicatives de la COVID-19**

**C./ C'est une personne atteinte d'anosmie (perte de l'odorat) ou d'agueusie (perte du goût) en l'absence de toute autre cause identifiée.**

**D./ C'est un décès, sans autre explication, d'un adulte qui a présenté une détresse respiratoire avant le décès ET qui a été en contact avec un cas probable ou confirmé de COVID-19 ou qui est relié sur le plan épidémiologique à un groupe de cas dans lequel il ya eu au moins un cas confirmé.**

✓ **Cas confirmé de COVID-19**

**C'est une personne présentant une infection par le virus par le virus de la COVID-19 confirmée en laboratoire, quels que soient les signes et symptômes cliniques**

**CONCLUSION**

La détection des cas de maladies et leur notification à travers la surveillance est une stratégie très importance en santé publique. Elle permet de signaler à temps à l'autorité compétente les cas pour prendre des décisions afin de limiter les flambées d'épidémies. Le système de surveillance des pays doit être efficace et performant. De cette efficacité et performance dépendront la validation des progrès vers l'élimination de la rougeole, le maintien de l'élimination du TNN et le contrôle la fièvre jaune.

# MONITORAGE ET L'EVALUATION DE LA COUVERTURE DES ACTIVITES

## Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L2 de comprendre le processus de réalisation d'un monitoring et l'évaluation de la couverture des activités d'un ESPC

## Objectifs spécifiques

A la fin du cours, il doit être capable

- 1) Définir les termes liés au monitoring et à l'évaluation
- 2) Décrire les quatre caractéristiques clés d'un bon indicateur pour le monitoring et l'évaluation des activités.
- 3) Expliquer les déterminants de la couverture pour le monitoring et l'évaluation des activités.
- 4) Représenter les valeurs des indicateurs sur un diagramme de couverture
- 5) Analyser les différents goulots d'étranglement pour ressortir les causes probables et les stratégies de résolution.

## I. GÉNÉRALITÉS

Dans le cadre de la politique de mise en œuvre des Soins de Santé Primaires notamment de la stratégie de suivi de l'enfant et de la femme enceinte, la Côte d'Ivoire avec l'appui des partenaires au développement attache une grande importance au processus de monitoring de couverture des activités.

Le monitoring permet d'évaluer localement la couverture des activités à partir des déterminants de la couverture. Il s'effectue périodiquement tous les six mois. Il permet d'identifier les problèmes de fonctionnement et de gestion qui entravent la bonne exécution des activités, d'analyser leurs causes, de déterminer et de planifier ensemble les mesures correctrices à mettre en œuvre par les agents de santé et la communauté locale en tenant compte des ressources disponibles.

## II. DÉFINITIONS OPÉRATIONNELLES DES TERMES LIÉS AU MONITORAGE

### ✓ **Monitoring**

Le monitoring est une activité qui permet de suivre l'avancement d'un programme. Il consiste à identifier les difficultés qui empêchent l'atteinte des objectifs au fur à mesure qu'ils se posent, et d'apporter des solutions correctrices pendant le temps imparti à l'exécution de cette activité.

### ✓ **Evaluation**

L'évaluation est une activité qui permet dans le cadre du monitoring à un moment donné, de déterminer [quel groupe a bénéficié du programme] dans quelle mesure et comment ?

### ✓ **Critère ou déterminant de la couverture**

C'est une caractéristique recherchée par un programme et qui doit être appréciée au cours du monitoring et de l'évaluation des activités.

Les déterminants de couverture retenus dans le cadre du monitoring et de l'évaluation des activités sont

1. La population cible ; Pop Cible
2. La disponibilité des ressources ; DR
3. L'accessibilité géographique ; AG
4. L'utilisation des services ; US
5. La couverture adéquate ; CA
6. La couverture effective ; CE

### 2.4 Indicateur

C'est une variable qui permet de mesurer les critères retenus dans le monitoring d'une activité

### 2.5 Couverture

C'est la population qui a bénéficié des activités d'un programme ou d'une action de santé.

### 2.6 Goulot d'étranglement

C'est un problème rencontré lors du monitoring et qui nécessite une action correctrice.

### 2.7 Diagramme de couverture

C'est la représentation graphique des valeurs des indicateurs

### III-CARACTÉRISTIQUES CLÉS D'UN BON INDICATEUR

Un bon indicateur doit être :

**Valable** : c'est-à-dire qu'il doit effectivement mesurer, ce qu'il est censé mesurer.

**Fiable** : c'est-à-dire que sa valeur doit être la même si deux personnes la mesurent.

**Approprié** : c'est-à-dire qu'il doit être adapté au contexte local.

**Mesurable** : c'est-à-dire qu'il peut être mesuré à partir des données et des instruments simples. *quantifier chiffre*

### IV. LES DÉTERMINANTS DE LA COUVERTURE

**4.1 La population cible (PC)** : c'est la population qui bénéficie d'un programme ou d'une activité donnée. Elle se calcule en tenant compte de la période couverte par le monitoring. *PC*

**Exemple** : Le centre de santé de Bazré a une population totale de 10.500 habitants en 2020. La période retenue pour le monitoring de l'activité de prévention de l'anémie chez les femmes enceintes part du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020 soit 6 mois.

La population cible du monitoring va se calculer selon les étapes suivantes :

- **Etape 1** : Identifier la proportion des femmes enceintes : 5% de la population totale.
- **Etape 2** : Calculer la PC annuelle =  $10500 \times 5 / 100 = 525$  femmes enceintes
- **Etape 3** : Calculer la PC du monitoring =  $525 / 2 = 263$  femmes enceintes à 260 environ

La PC annuelle est divisée par 2 parce que la période retenue pour le monitoring est de 6 mois.

#### 4-2 La disponibilité des ressources. *DR.*

La disponibilité des ressources peut être définie comme la quantité des ressources essentielles existantes par rapport à la quantité des ressources essentielles requises pour couvrir la totalité de la population cible pour une intervention donnée. *ressource disponible*

**Exemple** : En vous servant de la population cible des femmes enceintes ci-dessus calculée, la quantité totale de fer nécessaire pour que chaque femme enceinte reçoive toute la quantité de fer dont elle a besoin pendant la grossesse se calcule comme suit : Chaque femme enceinte reçoit selon les directives 30 gélules de complément ferrique par mois. Ainsi, elle recevra au total 270 gélules pendant toute la grossesse c'est à dire  $30 \times 9$  mois (9 mois représente la durée de la grossesse). *30 gélules/mois*

La quantité de fer requise sera égale :  $270 \text{ cp} \times 263$  ( 263 est la population cible des femmes enceintes), ce qui donne un total de 71.010 cp. Cette quantité est appelée **quantité essentielle de ressources requises**

Supposons que la quantité du fer en stock dans le centre à la veille du monitoring soit égale à 25.000 gélules. Cette quantité en stock est appelée **quantité de fer essentielle existante**

Le calcul de la disponibilité des ressources se fera comme suit :

$$DR = \frac{\text{Quantité de fer essentielle existante } Q.E.}{\text{Quantité de fer essentielle requise } Q.R.} \times 100$$

ou  $DR = \frac{25000}{71010} \times 100 = 35\%$  (considérer la partie entière sans arrondir)

#### 4.3 L'accessibilité géographique

L'accessibilité géographique se définit comme le pourcentage de la population cible qui habite dans un rayon spécifique du lieu de prestations où les ressources sont disponibles. Selon l'OMS, la population qui a accès à un service de santé est celle qui habite dans un rayon de moins de 5 km autour du centre de santé plus celle qui a bénéficié d'au moins une stratégie avancée pendant la période du monitoring.

Exemple : Supposons que 250 femmes enceintes de la localité habitent dans un rayon de moins de 5 km du centre de santé

Le calcul de l'accessibilité géographique se fera comme suit :

Effectif de femmes enceintes habitant dans un rayon de moins de 5 km du centre de santé

$$AG = \frac{\text{Effectif de femmes enceintes habitant dans un rayon de moins de 5 km du centre de santé}}{\text{La population cible du monitoring}} \times 100$$

$$AG = \frac{250}{263} \times 100 = 95\%$$

#### 4-4 L'utilisation de service

L'utilisation des services peut être définie comme le pourcentage de la population cible qui utilise le service au moins une fois au cours de la période couverte par le monitoring. Dans notre cas, les femmes enceintes qui auront utilisé le service de CPN sont celles qui auront reçu au moins une dose de fer des mains de la sage femme pendant la période retenue pour le monitoring.

Exemple : Considerons que 200 femmes enceintes ont reçu au moins une dose de fer des mains de la sage femme pendant la période du monitoring.

L'utilisation de service se calcule comme suit :

Nbre de femmes enceintes ayant reçu  
au moins une dose de fer pendant la période du monitoring

$$US = \frac{\text{Nbre de femmes enceintes ayant reçu au moins une dose de fer pendant la période du monitoring}}{\text{La population cible du monitoring}} \times 100$$

$$US = \frac{200}{263} \times 100 = 76 \%$$

#### 4.5 La couverture adéquate

La couverture adéquate peut être définie comme le pourcentage de la population cible qui utilise les prestations avec la fréquence et l'intensité (critère quantité) requises.

Ici les femmes enceintes qui ont une couverture adéquate sont celles qui auront pris le fer pendant toute la durée de la grossesse.

Exemple : Supposons que 55 femmes enceintes ont pris le fer pendant toute la durée de leur grossesse.

Nbre de femmes enceintes ayant pris le fer pendant  
toute la durée de leur grossesse

$$CA = \frac{\text{Nbre de femmes enceintes ayant pris le fer pendant toute la durée de leur grossesse}}{\text{Population cible du monitoring}} \times 100$$

$$CA = \frac{55}{263} \times 100 = 20 \%$$

#### 4.6 La couverture effective

La couverture effective peut être définie comme le pourcentage de la population cible ayant reçu les prestations en quantité suffisante (couverture adéquate) et avec une qualité qui correspond aux normes établies scientifiquement comme nécessaires pour avoir l'effet escompté.

Dans notre cas, les femmes enceintes qui ont une couverture effective sont celles qui auront pris le fer non seulement durant toute la durée de la grossesse, mais selon les directives nationales (c'est à dire 1cp/j pendant toute la durée de la grossesse)

Exemple : Supposons que 40 femmes enceintes ont pris le fer pendant toute la durée de la grossesse selon les directives nationales.

Le calcul de la couverture effective se fera comme suit :

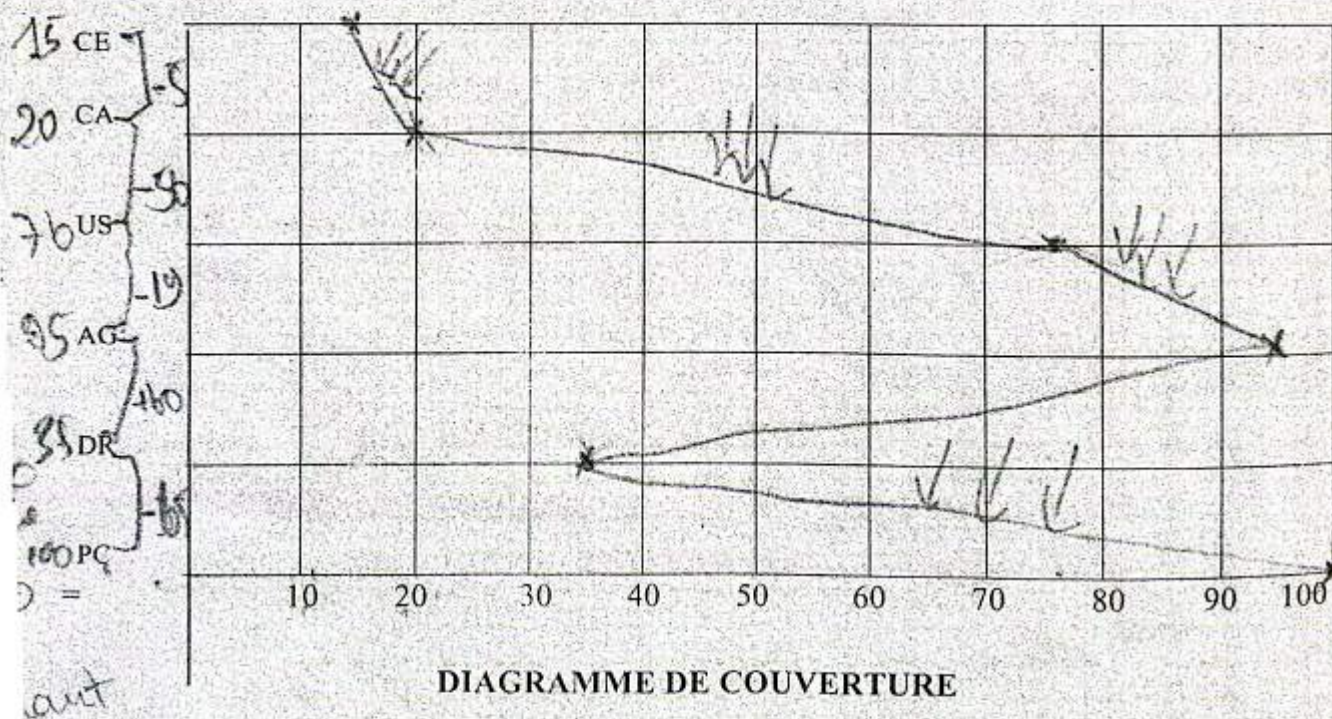
$$CE = \frac{\text{Nbre de femmes enceintes ayant pris le fer pendant toute la durée de la grossesse selon les directives nationales}}{\text{Population cible du monitoring}} \times 100$$

$$CE = \frac{40}{263} \times 100 = 15 \%$$

## V. DIAGRAMME DU COUVERTURE

C'est la représentation graphique des valeurs des indicateurs. Il comprenant une ligne des ordonnées (ligne verticale) sur laquelle sont notés les déterminants de la couverture et une ligne des abscisses (ligne horizontale) sur laquelle les valeurs des indicateurs sont mentionnées.

**Exercice :** A partir des indicateurs ci-dessus calculés, tracer dans la figure ci-dessous la courbe de couverture



toutes les fois que les courbes va vers la gauche il y a un saut d'échantillonnage

## VI. ANALYSE DES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE GOULOTS D'ÉTRANGLEMENT, LES CAUSES ET LES STRATÉGIES DE RÉOLUTION.

### 6.1 Analyse du goulot d'étranglement :

Dire que le goulot d'étranglement est situé par exemple entre l'AG et l'US est une analyse de ce goulots.

**Tableau n°1 :** Etude des principaux goulots d'étranglements dans le monitoring des activités au niveau d'un établissement sanitaire de premier contact (Analyse, Causes probables, Stratégies potentielles, Personne ou Structure chargée de la mise en œuvre des stratégies)

| Site du goulot d'étranglement | Analyse du goulot                                                                                                                          | Causes Probables                                                                                                                                                      | Stratégies                                                                                                                                                                                                               | Personne ou structure pour exécuter les stratégies                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entre la CA et la CE          | La population reçoit les soins en quantité et non en qualité                                                                               | Non maîtrise des techniques de soins par les agents de santé<br>Méconnaissance des normes exigées pour la qualité des soins<br>Absence ou insuffisance de supervision | Formation de l'IDE/SF sur les techniques des soins indiqués<br>Formation de l'IDE/SF sur les normes exigées pour la qualité des soins<br>Organisation ou intensification des supervisions                                | SUS<br>DD district<br>Le chargé de la formation continue<br>-ONG<br>-ECD<br>-Direction Régionale<br>-Direction Centrale<br>-Partenaires |
| Entre l'US et la CA           | La population vient une fois recevoir un soin, mais ne revient plus pour terminer la série de soins souhaitée pour avoir l'effet escompté. | Mauvais accueil des patients<br>Rendez-vous non mentionné dans le document de soins et non expliqué<br>Attente trop longue pour les patients<br>Apparition des MAPI   | Renforcement de capacité de l'IDE/SF sur l'accueil<br>Mention et explication des dates des RDV<br>Réduction du temps d'attente par une bonne organisation du service<br>Respect rigoureux de l'asepsie pendant les soins | ONG <i>équipe qui a été du district</i><br>ECD<br>Direction Régionale<br>Direction Centrale<br>Partenaires extérieurs                   |

|                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Entre l'AG et l'US   | La population a accès au service, mais ne le fréquente pas                                                              | Manque ou insuffisance d'informations de la population sur les activités du centre de santé<br><br>- Considérations socioculturelles                                           | Information de la population sur les activités du centre (utilisation des moyens locaux d'informations)<br><br>Sensibilisation de la population sur l'importance de fréquenter les services de santé en cas de besoin tout en respectant leurs coutumes                  | Agents de santé (Infirmier Sage-femme) Coges                                   |
| Entre la DR et l'AG  | Ressource disponible, mais la population n'y a pas accès parce qu'elle se trouve à + de 5 km ou + de 10 km pour les CSC | Inaccessibilité géographique de la population<br><br>Inexistence ou non fonctionnement des cases de santé                                                                      | Organisation des stratégies avancées<br><br>Ouverture ou redynamisation des cases de santé et formation des relais communautaires                                                                                                                                        | Infirmier (formation)<br>- Sage-femme (formation)<br>- Coges (choix des ASC)   |
| Entre la PC et la DR | Population cible présente, mais manque ou insuffisance de ressources (médicaments, vaccins etc.)                        | Rupture des ressources (vaccins, etc.)<br><br>Intervalle de commande trop long<br><br>Mauvaise estimation des besoins en ressources<br><br>Mauvaise estimation du dénominateur | Approvisionnement en ressources (Vaccins, etc.)<br><br>Réduction de l'intervalle de commande à un mois<br><br>Formation du personnel de santé sur l'estimation des besoins en ressources concernées<br><br>Formation du personnel de santé sur le calcul du dénominateur | - Infirmier<br>- Sage-femme<br>- Coges<br>- Médecin chef du district Sanitaire |

# BUDGETISATION DES RESSOURCES PROPRES D'UN ESPC DANS LE CADRE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES

## Objectif général

Ce cours vise à permettre à l'étudiant IDE/SF/M de la L2 de comprendre le processus d'élaboration du budget d'un ESPC à partir des ressources propres dans le cadre des interventions des SSP

## Objectifs spécifiques

A la fin du cours, il doit être capable de :

- 1) Définir le terme suivants : ressources brutes, ressources propres, budget .
- 2) Enumérer les deux composantes d'un budget .
- 3) Enumerer trois caractéristiques du budget d'un ESPC ;
- 4) Expliquer les quatre rubriques du budget d'un ESPC.
- 5) Définir le terme reserve supplémentaire

## INTRODUCTION

Une bonne gestion financière est celle qui établit un ordre de priorité au niveau des dépenses. Les activités de gestion des SSP recommandent que les ressources financières issues du recouvrement des coûts des actes de santé soient budgétisées avant d'être dépensées. IL est donc important que l'infirmier et la sage femmes, responsable des structures sanitaires périphériques rurales connaissent le mécanisme de l'élaboration du budget

## 1. DÉFINITIONS DES TERMES

### 1.1 Recette brute (RB)

C'est la somme totale recouvrée par les agents de santé (infirmiers, sage-femme) et le personnel de relais (ASC, AT) au cours d'une période donnée à partir des actes de santé (consultation de soins, accouchement, pansements, injections petites chirurgies, etc.) et de la vente des carnets de santé

### 1.2 Ressource propres (RP)

C'est la somme total disponible pour le centre au cours d'une période donnée après les différentes dépenses du centre. Elle est aussi appelée recette des six mois couverts par le monitoring ou somme à budgétiser.

### 1.3 Domaines de dépenses d'un ESPC

#### ✓ Le Fonds d'Action Sociale (FAS) :

C'est une sorte d'impôt prélevé sur les recettes. Il correspond à **10%** des recettes brutes. Il doit être déposé chaque mois au bureau du district sanitaire.

#### ✓ L'Interessement du Personnel (IP) :

C'est une sorte de motivation que le comité de gestion verse à l'infirmier et la sage-femme pour ses activités au sein du Coges. Il correspond à **15%** des recettes brutes. Il doit être réparti équitablement entre les deux.

#### ✓ Le Salaire du personnel de Soutien (SPS)

C'est la paie du personnel d'aide et de soutien recruté par le Coges à la demande de l'infirmier ou la sage-femme pour des activités spécifiques à leurs besoins. Il correspond à **20%** des recettes brutes.

#### ✓ Formule

$$\text{Ressource propre} = \text{Recettes Brutes} - \text{Total de dépenses du centre (FAS + IP + SPS)}$$

### 1.4 Budget

Dans le cadre de la gestion des activités des SSP, le budget est l'expression chiffrée des activités des structures sanitaires au niveau rural (centre de santé rural, dispensaire rural et maternité rurale) au cours d'une période donnée.

## II. LES COMPOSANTES DU BUDGET.

Le budget des structures rurales se compose de deux parties :

### 2.1 L'investissement

- Achat des équipements du centre (mobylette et accessoires, réfrigérateur)
- Construction d'un hanger ou préau pour la vaccination par exemple.

### 2.2 Le fonctionnement

- Salaires du personnel non pris en charge par l'Etat ;
- Entretien courant des locaux, du matériel et du mobilier ;
- Fournitures techniques et administratives ;
- Consommation d'eau et d'électricité.)
- Bouteille de gaz pour les réfrigérateurs à gaz pour les centres non électrifiés

### III. CARACTERISTIQUES DU BUDGET D'UN ESPC DU NIVEAU RURAL.

- Le budget est élaboré tous les six mois en Côte d'Ivoire. Il se fait dans la même période que le monitoring des activités. Il peut se faire aussi annuellement
- Le budget n'est pas prévisionnel. Il est disponible car il représente les recettes des six mois correspondant à la période du monitoring.
- Le budget est la répartition des dépenses à partir de la somme recueillie pendant les 6 mois correspondant à la période du monitoring ;
- Le budget couvre les dépenses de la structure sanitaire rurale pour les 6 prochains mois à partir de la période du monitoring.

### IV. LES RUBRIQUES ENTRANT DANS L'ÉLABORATION DU BUDGET D'UN ESPC DANS LE CADRE DES SSP SONT

- Le fonds de réserve (FR) ;
- La somme à budgétiser (SAB) ;
- Les dépenses obligatoires (DO) ;
- Les dépenses de fonctionnement locales (DFL) ;

#### 4.1 Fonds de réserve (FR)

Le fond de réserve du centre correspond à la somme réellement à la banque à la veille du monitoring. Le calcul du fonds de réserve doit tenir compte des mouvements sur le compte à savoir les intérêts et les agios.

Le fonds de réserve est le solde du centre à la date du monitoring non compris les recettes des six mois correspondant à la période du monitoring si celle-ci ont été versées sur le compte.

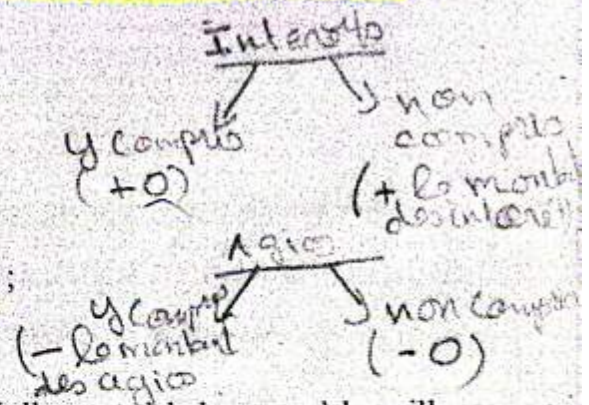
Le Fonds de réserve se calcule en soustrayant de la somme à la banque à la date du monitoring, les recettes des six mois correspondant à la période du monitoring si celles-ci ont été déposées sur le compte.

✓ Formule

**FR = Somme à la banque à la veille du monitoring – Recettes des six mois correspondant à la période du monitoring si elles sont déposées sur le compte.**

#### 4.2 La somme à budgétiser (SAB)

C'est le total des recettes des six mois correspondant à la période du monitoring. Elle se compose de deux parties :



**4.2.1 Les recettes issues de la vente des médicaments essentiels (RVME).** Elles correspondent au total des recettes de la vente des médicaments essentiels effectivement versées à la nouvelle pharmacie de la santé publique (PSP) du district sanitaire.

Signalons dans le calcul des RVME, les dépôts non justifiés par des reçus de versements ne sont pas pris en compte.

#### **4.2.2 Les recettes du comité de gestion ou recettes du coût des actes de santé**

C'est la somme issue du coût des actes de santé (consultation, vente de carnets, etc.)

Elle se calcule en additionnant les recettes issues de la vente des médicaments essentiels (RVME) et les recettes issues du coût des actes de santé (RCAS).

##### ✓ Formule

SAB = Recettes issues de la vente des médicaments essentielles + Recettes issues du coût des actes de santé

#### **4.3 Les dépenses obligatoires (ou dépenses incompressibles)**

DO

Ce sont les dépenses qui sont indispensables au bon fonctionnement du centre, c'est à dire des dépenses sans lesquelles le centre ne peut fonctionner.

Elles se composent de trois éléments :

- la disponibilité en médicaments essentiels (médicaments génériques) ;
- la disponibilité en outils de gestions ( les différents registres);
- la disponibilité des activités de vaccination ( caburant pour stratégie avancé, paiement des factures de l'électricité, etc.)

##### ✓ Formule

Dépense obligatoire = Somme à budgétiser – Dépenses de Fonctionnement local

#### **4.4 Les dépenses de fonctionnement local.**

DFL

Elles sont moins indispensables que les dépenses obligatoires et regroupent les chapitres suivants :

- Matériel et fourniture de bureau pour fonctionnement (stylos, cahier, etc.);
- Matériel d'entretien (savon, balai, râtelier, pelle etc) ;
- Entretien du local (frais de désherbage de la cour du centre , vidange de la fosse septique, etc.) ;

- Emballage de petit matériel médical (sachets plastiques pour le conditionnement des médicaments par exemple) ;
- Entretien de la moto (frais de lubrifiant, frais de petites réparation, les pneumatiques etc.) ;
- Matériel divers (serrures, chaises ou tables, matelas, ampoules à changer etc.).
- Immeuble : frais de réparation éventuelle. Ils ne doivent pas excéder 10% des fonds alloués à la rubrique des dépenses de fonctionnement local.
- Imprévu : frais bancaire, carburant pour les urgences. Ils ne doivent pas excéder 5% des dépenses de fonctionnement local.

✓ Formule

Dépenses de fonctionnement local = Somme à budgétiser – Dépenses Obligatoires

#### V Réserve supplémentaire éventuelle :

C'est la somme qui pourrait éventuellement restées après les dépenses. Elle est généralement ajoutée sur le fonds de reserve. Elle pourrait aussi servir à interresser les membres communautaires du Coges à travers un système mis en place au cours du programme

#### CONCLUSION

La budgétisation des ressources propres d'un ESPC est une activité de gestion dans le cadre des activités des Soins de Santé Primaires. Elle permet à l'agent de santé de suivre les recettes et les dépenses du centre de santé, d'accroître l'efficacité dans le fonctionnement du centre par la priorisation dans le financement des activités.

Les agents de santé doivent effectuer cette activité si nous voulons perenniser le financement de nos structures sanitaires..